胃不好、吃不胖：胃溃疡、胆汁反流、印戒细胞癌和瘦人增重

“胃不好”到底是哪一种；家里有人得胃癌怎么办；怎样防、怎样查、怎样治；瘦人怎样长肉

约 2.8 万字 · 细读约 60 分钟 · 31 章 · 56 条资料出处

胃疼、胃胀、反酸、体检单上的“胃炎”“胆汁反流”“幽门螺杆菌阳性”；家里长辈得过胃溃疡、胃癌；还有怎么吃也不长肉。这一篇先把“胃不好”分成五种，再一样一样讲：**溃疡、胆汁反流、胃癌的两种类型和印戒细胞癌、家族与遗传、胃镜正常的“胃不好”**，各自怎样一级预防、二级预防和治疗；最后用一整部分讲**瘦人怎样健康增重**。幽门螺杆菌的细节见第 9 篇。

先说结论

先分清是哪一种

“胃不好”至少有五种：细菌、溃疡、反流、功能性的、肿瘤。办法各不相同，先弄清再治

溃疡：两个主因

幽门螺杆菌和止痛药。杀了菌，溃疡一年内复发从六成降到一成多；黑便、呕血马上就医

胆汁反流：多半不是大病

切过胆囊、做过胃手术的人常见；和癌前病变有关联，但证据不硬；有几种药能缓解症状

家里有人得胃癌

风险是别人的两倍以上，原因是共同的细菌、饭桌和少数的基因。杀菌能把风险减掉一半多

印戒细胞癌

年轻人、女性相对多；早期发现预后不差，晚期很凶。早发现靠胃镜，不靠症状

吃不胖

先排除疾病；多数是体质，不是“吸收不好”。少量多餐、喝进去的热量、蛋白质加力量训练

下面先画一张“胃不好”的地图，再一种一种讲，最后讲增重和预防总表。医学研究都在 PubMed 上核对过摘要；“编者的理解”只供参考。**本篇不能代替医生的诊断和处方；用药、停药、做不做胃镜，一定先问医生。**

目录

第一部分 · 先把“胃不好”分清楚

01 小何一家三代的胃

02 “胃不好”的五种情况：一张地图

03 有多常见：几组数字

第二部分 · 胃是怎样受伤的

04 胃为什么不会把自己消化掉

05 胃是有“情绪”的器官

第三部分 · 幽门螺杆菌：要点重提

06 幽门螺杆菌：五个要点

07 四联药太难受，怎么办

第四部分 · 胃溃疡和十二指肠溃疡

08 溃疡是什么

09 溃疡的两个主因，和几个帮凶

10 溃疡最怕的三件事

11 溃疡怎样治，怎样不复发

12 溃疡的一级预防和二级预防

第五部分 · 胆汁反流性胃炎

13 胆汁反流：一道没关严的门

14 胆汁反流会变成癌吗

15 胆汁反流怎样治

第六部分 · 胃癌、印戒细胞癌和家族

16 胃癌有两种长法

17 印戒细胞癌：早期和晚期，是两回事

18 爷爷是胃癌，我会不会也得

19 真正“遗传”的胃癌：很少见，但要认得

20 胃癌的一级预防和二级预防

第七部分 · 胃镜正常，胃却难受

21 功能性消化不良：胃镜正常，不等于“没病”

第八部分 · 吃不胖：瘦人怎样健康增重

22 瘦，算不算问题

23 为什么吃不胖：三种不同的瘦

24 先排除疾病：哪些情况要去查

25 胃不好和吃不胖，有没有关系

26 怎样增重：七条办法

27 一天怎样安排：给胃不好的瘦人

28 为什么胖了两斤，又掉回去

第九部分 · 预防总表与结语

29 一张总表：每一样怎样防、怎样查、怎样治

30 常见的问题

31 结语：小何后来

第一部分

先把“胃不好”分清楚

01 小何一家三代的胃

小何三十四岁，做软件开发。他们家三代人，胃都“不太好”。

- **爷爷**六十多岁查出胃癌，发现时已经是晚期，不到一年就走了。
- **父亲**年轻时常常半夜胃疼，吃块饼干能好一点。五十岁那年有一天拉出黑得像柏油的大便，人一下子站不住，送到医院，说是十二指肠溃疡出血。
- **小何自己**从小就瘦，一米七二，体重常年在五十三公斤上下。饭量不算小，偶尔胖两三斤，忙一阵又掉回去。他总觉得自己是“吸收不好”。

今年体检，他呼气试验阳性。医生让他做了胃镜，报告上写着：“慢性非萎缩性胃炎伴糜烂，胆汁反流。”

医生开了两个星期的四联药。吃到第五天，他嘴里发苦，恶心，一点胃口都没有，就自己停了。朋友给他推荐了一种益生菌，说“养一养就好了”。

晚上他睡不着，翻手机，看到一个词叫“印戒细胞癌”，说是年轻人也会得，而且很凶。他越想越怕：

- 爷爷是胃癌，我是不是早晚也会得？这东西遗传吗？
- 父亲的溃疡，和我的胃炎，是一回事吗？
- 胆汁反流要不要紧？会不会变成癌？
- 四联药这么难受，能不能用益生菌代替？
- 我这么瘦，是不是胃的问题？怎样才能长几斤肉？

小何一家是编者为了说明而写的人物。但这五个问题，是很多家庭真实的问题。

先说结论：**“胃不好”不是一种病，是好几种不同的事叠在一起。**把它们一样一样分开，每一样都有比较清楚的办法：该杀菌的杀菌，该查胃镜的查胃镜，该放下心的放下心。至于“吃不胖”，多半不是胃的错。

这一篇怎样读

- **幽门螺杆菌和胃癌的细节，**本站健康栏目第 9 篇《幽门螺杆菌与胃癌》已经写过（怎样查、怎样看报告、四联和二联、益生菌、孩子要不要查）。这一篇只重提要点，把篇幅留给第 9 篇没讲透的：**溃疡、胆汁反流、印戒细胞癌和家族遗传、胃镜正常的“胃不好”、吃不胖**。
- **只关心增重的，**可以直接跳到第八部分。
- **资料都有出处。**医学研究都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，点正文里的小数字可以看到。
- **分清证据的分量。**“随机对照试验”是把人随机分成两组来比，最有说服力；“观察研究”只能看出“有关联”，不一定是“因为所以”。
- **编者的理解**会标出来。**这一篇不能代替医生的诊断和处方**；吃药、停药、做不做胃镜，都要问医生。

02 “胃不好”的五种情况：一张地图

人们说“胃不好”，可能指的是胃疼、胃胀、反酸、烧心、嗳气、恶心、吃一点就饱、没胃口，也可能只是体检单上的一行字。它背后大致是五类情况：

图 1 “胃不好”的五种情况



几种可以同时存在；症状的轻重和病的轻重常常对不上

哪一类	怎么回事	靠什么确定
一、幽门螺杆菌胃炎	胃里住着一种细菌，长期引起炎症；多数人没感觉	呼气试验
二、溃疡	胃或十二指肠的内壁被“蚀”出一个坑	胃镜
三、反流	胃酸往上反到食管（烧心、反酸），或者胆汁往回反到胃里	症状和胃镜
四、功能性消化不良	胃的结构是好的，但蠕动和感觉出了问题：胀、早饱、隐痛	胃镜正常，排除了别的
五、肿瘤和癌前病变	萎缩、肠化、异型增生，直到胃癌	胃镜加活检

这五类有三个特点，记住了就不容易乱：

- **它们可以同时存在。**小何的报告就是第一类加第三类；他的不舒服里可能还有第四类。
- **症状的轻重，和病的轻重，对不上。**功能性消化不良可以难受得吃不下饭，胃镜却干干净净；早期胃癌和不少溃疡，反而一点感觉都没有。
- **真正要命的是第五类，而它最不靠症状发现。**所以该做胃镜的时候，不能用“我没什么感觉”来推。

还有两种“胃疼”其实不是胃：

- **心脏。**心梗有时表现为上腹痛、恶心，尤其是中老年人、有三高的人。上腹痛伴着出冷汗、胸闷、气短，先想到心脏，马上打急救电话。
- **胆囊和胰腺。**吃了油腻以后右上腹或上腹正中剧痛、往后背窜，要想到胆结石、胰腺炎。

03 有多常见：几组数字

幽门螺杆菌。2021 年全国 29 个省份、一万多个家庭的调查：大约每 10 个人里 4 个感染（40.66%）[1]。

溃疡。上海做过一项很难得的研究：不是在医院里数病人，而是在居民里随机抽人，请他们来做胃镜。1,022 位做了胃镜的居民里[2]：

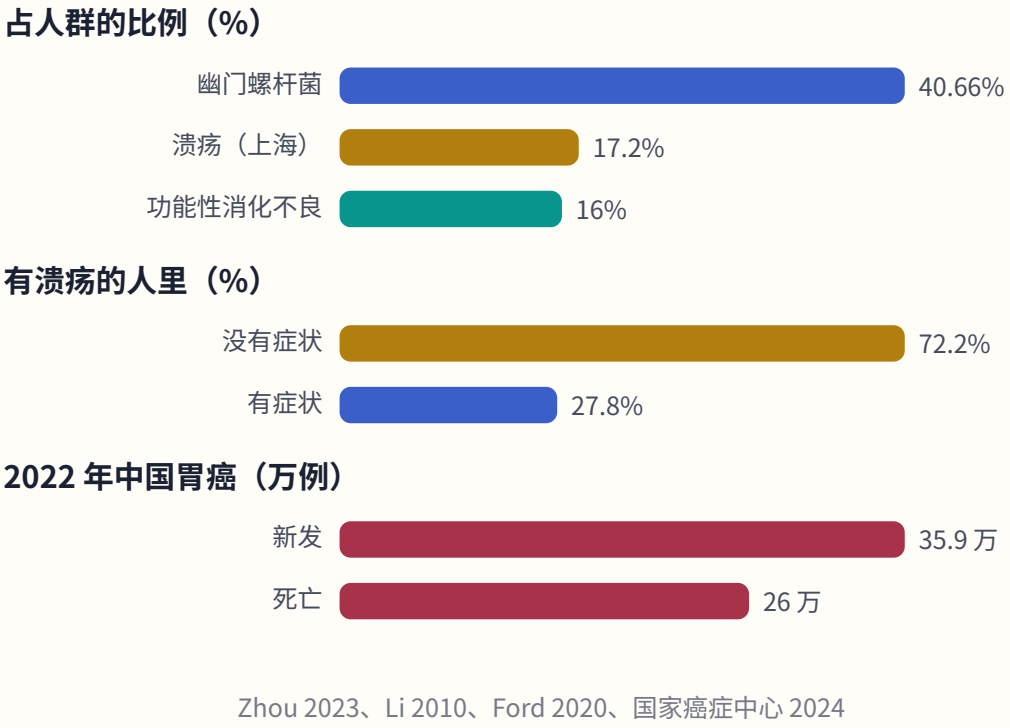
- **17.2% 的人有消化性溃疡**（十二指肠溃疡比胃溃疡多一倍多）；西方类似的调查大约是 4%；
- 有溃疡的人，92.6% 感染了幽门螺杆菌；
- **有溃疡的人里，72.2% 没有任何上消化道的症状。**

这项调查做得比较早（2010 年发表），当时上海居民的幽门螺杆菌感染率高达 73.3%。这些年感染率下降了，抑酸药也普及了，溃疡比二十年前少了很多[3]；全世界的研究大多显示溃疡的发病在下降[4]。但“大部分溃疡没有症状”这一点，至今仍然是提醒。

功能性消化不良。在普通人群里，多达 16% 的人受它影响；因为消化不良去看病的人，大约 80% 查不出结构上的原因，属于这一类[5]。

胃癌。国家癌症中心估计，2022 年中国新发胃癌约 35.9 万例，在所有癌症里排第五；死亡约 26.0 万例，排第三[6]。好消息是：2000 到 2018 年，胃癌的发病率和死亡率都在逐年下降[6]。

图 2 有多常见



Zhou 2023、Li 2010、Ford 2020、国家癌症中心 2024

把这些数字放在一起看：

- “胃不好”的人里，**最多的是功能性消化不良和幽门螺杆菌胃炎**，它们不要命；
- **溃疡不少，而且常常不声不响**，第一次露面可能就是出血；
- **胃癌在减少，但仍然是中国第三位的癌症死因**，值得认真预防。

第二部分

胃是怎样受伤的

04 胃为什么不会把自己消化掉

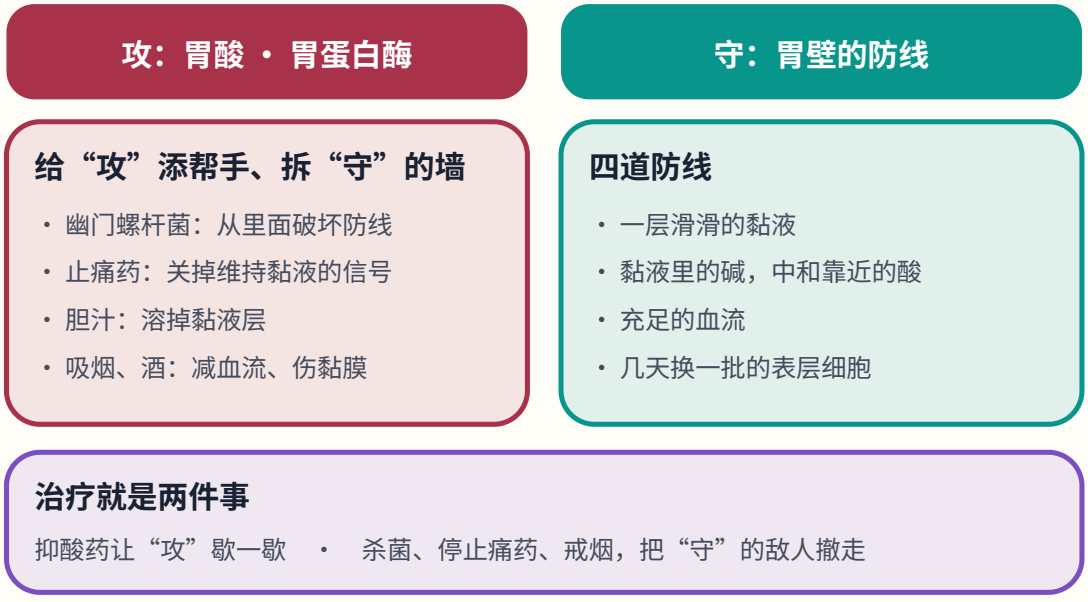
胃每天分泌一两升胃液。里面的胃酸，酸度和稀盐酸差不多；里面的胃蛋白酶，专门分解蛋白质。而胃壁自己，也是蛋白质做的。

胃之所以没有把自己消化掉，是因为它有一套防御：

- **一层黏液。**像一层滑滑的凝胶，盖在胃的内壁上。
- **黏液里的“碱”。**胃壁往黏液里分泌碳酸氢盐，把靠近细胞的那一层中和掉。所以胃腔里很酸，紧贴细胞的地方却接近中性。
- **充足的血流。**带来养分，带走渗进来的酸。
- **飞快的更新。**胃的表层细胞几天就换一批，小破损很快补上。

可以把它想成一场天天在打的**攻防战**：一边是“攻”（胃酸、胃蛋白酶），一边是“守”（黏液、血流、修复）。平时守得住。

图 3 胃里的攻防战



守得住就平安；防线有了缺口，胃酸才得以下手

胃的病，大多可以归到一句话：**守的一方被削弱了，或者攻的一方添了帮手。**

- **幽门螺杆菌：**钻到黏液层底下住下来，长期引起炎症，把防线从里面破坏。
- **止痛药（阿司匹林、布洛芬这一类）：**它们止痛的原理，恰好也关掉了胃维持黏液和血流的信号。
- **胆汁：**本来该在肠子里，反流到胃里，胆汁酸能溶掉黏液层。
- **吸烟：**减少胃黏膜的血流，拖慢修复。
- **酒：**高浓度的酒直接损伤黏膜。

明白了这场攻防战，后面的治疗也就好懂了：**抑酸药是让“攻”的一方歇一歇；杀菌、停止痛药、戒烟是把“守”的一方的敌人撤走。**

05 胃是有“情绪”的器官

还有一样东西，不在上面的攻防战里，却管着胃的大半感觉：**神经**。

胃和肠的壁里，有一张自己的神经网，神经细胞的数量非常多，有人把它叫作“第二大脑”。它通过迷走神经和大脑时刻通话：大脑紧张，胃就蠕动乱、排空慢、对正常的胀也觉得疼；胃不舒服，又会让人更焦虑。

所以很多人都有这样的体验：一着急就胃疼，一生气就吃不下，考试前恶心，出差换个地方就胀。这不是“装的”，也不是“想出来的”，是神经在起作用。

这一条线索，后面会反复出现：

- 功能性消化不良，主要就是胃和大脑之间的通话出了毛病（见第 21 章《功能性消化不良：胃镜正常，不等于“没病”》）；
- 精神压力大的人，溃疡也更多（见第 9 章《溃疡的两个主因，和几个帮凶》）；
- 有些人吃不胖，和压力大、吃饭匆忙、没胃口有关（见第 23 章《为什么吃不胖：三种不同的瘦》）。

箴言里有一句关于饭桌的话：

> 吃素菜，彼此相爱，强如吃肥牛，彼此相恨。
>
> 箴言 15:17

这话讲的是家里的和睦比饭菜要紧。从胃的角度看，它也是实情：**同一顿饭，在什么心情下吃，胃的反应不一样。**

第三部分

幽门螺杆菌：要点重提

06 幽门螺杆菌：五个要点

这只细菌的来龙去脉，第 9 篇《幽门螺杆菌与胃癌》用了三十多章来讲。这里只重提五个要点，后面几部分都要用到。

一、它是很多胃病共同的“根”。慢性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、胃癌，背后最常见的原因都是它。

二、它在家里传。主要是口对口、共用餐具、嚼饭喂孩子。全国家庭调查里，家里有人感染，别人感染的机会就高；用公勺公筷的家庭感染率较低[1]。这就是“祖辈胃癌，后辈胃也不好”最常见的解释：**一家人共用一种细菌，不一定是共用一种基因**（见第 18 章《爷爷是胃癌，我会不会也得》）。

三、杀菌就是防胃癌，有随机试验为证。

- 山东临朐 18 万人的社区试验，跟踪近 12 年：杀菌组胃癌少约 14%，真正杀成功的人少约 19%[7]；
- 同在临朐的另一项试验跟踪了 22 年：胃癌发病约少一半[8]；
- **韩国的试验专门找父母或兄弟姐妹得过胃癌的人：杀菌组约 9 年后胃癌少了约 55%**[9]；
- 全球 24 项研究汇总：杀菌后胃癌发病约降低 47%[10]。

四、越早杀越好。在胃黏膜还没有萎缩、肠化以前杀，好处最大。

五、杀完一定要复查。停药至少四个星期以后再吹一次气。吃过药不等于杀干净了。

所以对小何来说，最要紧的一件事已经很清楚：**爷爷是胃癌，自己又是阳性，这一次的杀菌必须做完、做成功。**这比他担心的任何别的事，都更能改变他以后得胃癌的机会。

07 四联药太难受，怎么办

小何吃到第五天自己停了药。这是最常见、也最可惜的一种情况：**药没吃够，细菌没杀死，还可能逼出耐药来**，下一次更难治。

四联为什么难受？它是一种抑酸药加两种抗生素再加铋剂，一共吃十天到两周。常见的不舒服是嘴里发苦、有金属味，恶心，没胃口，肚子胀，拉肚子，大便发黑（铋剂引起的，是正常的）。这些在停药后会消失。

难受，不要自己停，回去找医生。办法有好几种：

一、换成“二联”。只用两种药：一种强力的抑酸药（伏诺拉生，或者大剂量的“拉唑”类），加阿莫西林。中国 2022 年的指南认为，大剂量二联和铋剂四联同样有效[11]。深圳的一项随机试验里，二联的根除率是 96.0%，四联是 92.0%；**出现副作用的，二联 39%，四联 71%**[12]。对青霉素过敏的人不能用这个方案，医生会另选。

二、调整四联里的抗生素。不同的抗生素，副作用不一样。

三、想办法把这两个星期撑过去。按时按量；抗生素饭后吃；这两周吃清淡一点，绝对不喝酒；嘴苦可以含点东西。

益生菌能不能代替？不能。汇总分析里，单吃益生菌，只有大约 14% 的人能把细菌清掉[13]。也就是说，七个人里有六个，细菌还在。

益生菌可以做的是“帮手”：和杀菌药一起吃，有可能减轻拉肚子等副作用（详细的证据见第 9 篇）。

有人说“吃了益生菌，胃舒服多了”。这可能是真的，但要分清两件事：

- **胃舒服了，**可能是因为停了刺激胃肠的抗生素，可能是饮食作息变了，也可能是功能性消化不良本来就时好时坏（见第 21 章《功能性消化不良：胃镜正常，不等于“没病”》）；
- **细菌还在不在，**是另一回事，只有呼气试验能回答。

对有胃癌家族史的人，“舒服了”远远不够。**要的是那张“阴性”的复查单。**

第四部分

胃溃疡和十二指肠溃疡

08 溃疡是什么

溃疡，就是胃或十二指肠的内壁上，被胃酸“蚀”出了一个坑。它比“糜烂”深：糜烂只伤到最表面一层，像擦破了皮；溃疡穿过了黏膜，像挖了一个洞。

按位置分两种，合起来叫“消化性溃疡”：

	十二指肠溃疡	胃溃疡
位置	胃的出口下面那一小段肠子	胃里面
谁多	中青年多	年纪大一些的人多
和细菌的关系	约 95% 和幽门螺杆菌有关	约 70% 和幽门螺杆菌有关
传统说的疼法	饿的时候、半夜疼，吃点东西好一些	吃完饭以后疼
会不会是癌	几乎不会	**少数“溃疡”其实是癌，必须活检、必须复查**

表里和幽门螺杆菌有关的比例，出自考克兰综述[14]。

“饿了疼、吃了好”还是“吃了疼”，是老一辈医生总结的规律，小何父亲的“半夜疼，吃块饼干好一点”就是典型的十二指肠溃疡。但**这个规律并不可靠**：前面说过，上海的调查里七成多的溃疡根本没有症状[2]。年纪大的人、长期吃止痛药的人，尤其容易“不疼”。

所以，**溃疡只能靠胃镜确定**，不能靠疼不疼、怎么疼来猜。

09 溃疡的两个主因，和几个帮凶

溃疡的原因，现在很清楚。主要是两个：

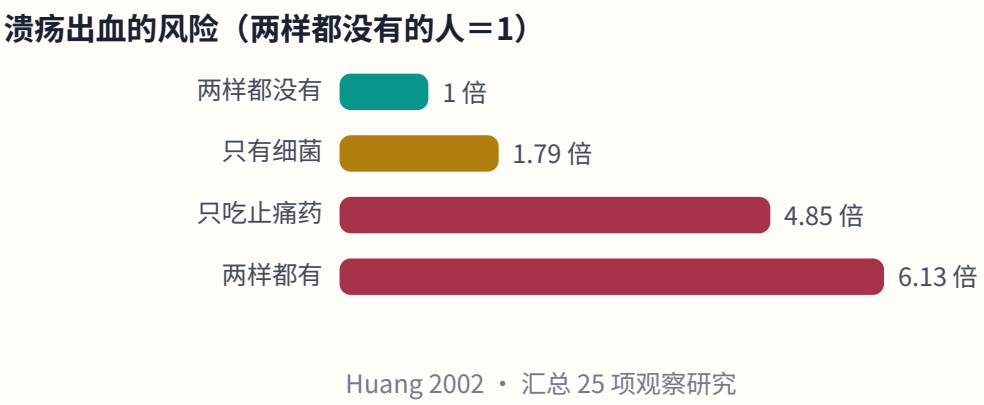
一、幽门螺杆菌。

二、止痛药。医学上叫“非甾体抗炎药”，包括阿司匹林、布洛芬、双氯芬酸、萘普生等等。很多感冒药、止痛片、治关节痛的药里都有它们；很多老人每天吃小剂量的阿司匹林保护心脑血管。

一项汇总 25 项研究的分析，把这两个原因的分量算得很清楚[15]：

- 幽门螺杆菌和止痛药，**各自独立**地增加溃疡和溃疡出血的风险；
- 两样凑在一起，风险叠加得更高。溃疡出血的风险：只有细菌，约 1.8 倍；只吃止痛药，约 4.9 倍；**两样都有，约 6.1 倍**；
- 反过来，**既没有细菌、又不吃止痛药的人，很少得溃疡。**

图 4 溃疡出血：细菌和止痛药，各算各的，还会叠加



Huang 2002 • 汇总 25 项观察研究

帮凶之一：精神压力。在发现幽门螺杆菌以前，人们以为溃疡是“愁出来的”。发现细菌以后，又有人说压力和溃疡无关。丹麦的一项研究给了比较公允的答案：研究者给 3,379 名没有溃疡的成年人做了压力评分，然后跟踪了十一二年[16]。

- 压力最大的三分之一的人，3.5% 得了溃疡；压力最小的三分之一，是 1.6%；
- 这个差别，不管有没有幽门螺杆菌都存在；
- 其中一部分是因为压力大的人更爱吸烟、更常吃止痛药、更少运动；把这些都算进去以后，压力本身的影响变小了，但仍然在。

帮凶之二：吸烟。它在上面这项研究里是独立的危险因素[16]，也让溃疡更难愈合。

不是原因的：吃辣、喝咖啡、吃饭不定时。编者没有找到可靠的证据说它们会“吃出”溃疡。不过已经有溃疡的人，吃了什么更疼，就先不吃它。

编者的理解：溃疡不是“胃酸太多”这么简单，是防线先被细菌或止痛药打开了缺口，胃酸才得以下手。所以**只吃抑酸药，是治标；把细菌杀掉、把止痛药停掉或换掉，才是治本。**

10 溃疡最怕的三件事

溃疡本身的疼，可以忍；它的并发症，会要命。小何父亲那一次，就是第一种。

一、出血。溃疡蚀到了血管。

- **黑便：**大便又黑又亮又黏，像柏油，有一股特别的腥臭。这是血在肠子里被消化以后的样子。
- **呕血：**吐出来的是鲜血，或者像咖啡渣一样的东西。
- 出得多时：头晕、心慌、出冷汗、眼前发黑、一站起来就要倒。

二、穿孔。溃疡把胃壁或肠壁蚀穿了。表现是**突然的、刀割一样的上腹剧痛**，很快蔓延到整个肚子，肚子硬得像木板，不敢动、不敢喘大气。

三、梗阻。胃的出口反复溃疡、结疤，变窄了。表现是饭后胀得厉害，呕吐，吐出来的是隔夜的食物。

这些情况，马上去急诊

- 黑便或呕血（注意：吃铋剂、补铁剂的人大便本来就会发黑；但如果同时头晕、心慌、出冷汗，照样马上去）；
- 突然发生的剧烈上腹痛，肚子发硬；
- 反复呕吐，吐隔夜的食物。

去医院的路上不要再吃东西、喝水，把最近吃过的药（尤其是止痛药、阿司匹林、抗凝药）告诉医生。

吃阿司匹林的老人，要不要先查细菌？

英国做过一项很大的试验：从 3 万多名 60 岁以上、长期吃小剂量阿司匹林的人里，找出 5,352 名幽门螺杆菌阳性的，随机分成两组，一组杀菌，一组吃安慰剂[17]。

- 头两年半里，因为溃疡出血住院或死亡的，杀菌组 6 例，安慰剂组 17 例，**少了约三分之二**；
- 但两年半以后，这个差别不见了。

作者的结论是：杀菌能预防阿司匹林引起的溃疡出血，但效果可能不持久[17]。

编者的理解：家里长辈要长期吃阿司匹林或别的止痛药、抗血小板药的，**值得先吹一次气，阳性就杀掉**；年纪大、以前有过溃疡或出血的，医生常常还会加一种护胃的抑酸药。这些都请和医生商量，不要自己给老人停阿司匹林。

11 溃疡怎样治，怎样不复发

溃疡的治疗，是现代医学里“把一种病基本拿下”的例子。四十年前，反复发作的溃疡常常要开刀切胃；现在几乎都能用药治好。

图 5 查出溃疡以后：五步



编者整理 · 具体疗程由医生定

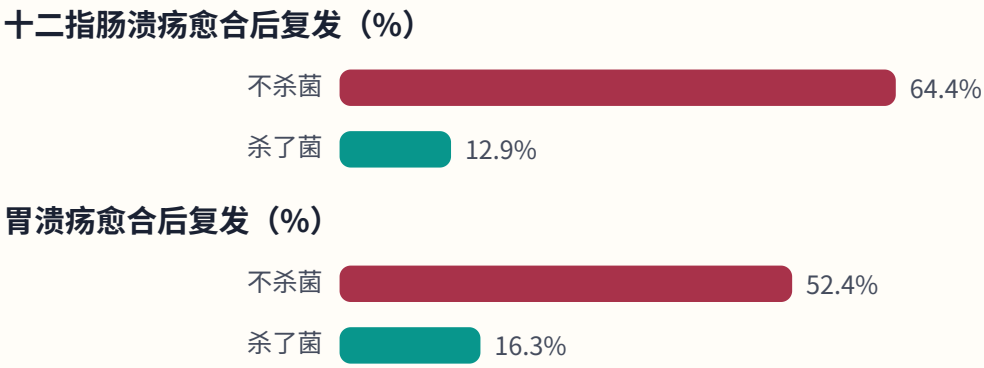
第一步：抑酸，让它长好。用“拉唑”类的抑酸药（质子泵抑制剂）或伏诺拉生，把胃酸压下去，溃疡就能自己愈合。一般十二指肠溃疡吃四到六周，胃溃疡吃六到八周，由医生定。疼常常几天就好了，但**坑还没长平，药要吃满疗程**。

第二步：查细菌，阳性就杀。这是不复发的关键。

考克兰综述汇总了 55 项随机试验[14]：

- **十二指肠溃疡：**不杀菌，溃疡长好以后有 64.4% 的人复发；杀了菌，只有 12.9%；
- **胃溃疡：**不杀菌，52.4% 复发；杀了菌，16.3%。

图 6 杀不杀菌，溃疡复发差好几倍



Ford 2016 考克兰综述 · 随机试验的汇总，证据质量评为低到很低

这些试验比较老，综述的作者把证据质量评为“低”到“很低”[14]；但几十项试验方向一致，这个结论今天没有人怀疑。从前人们说溃疡“好了又犯，犯了又好，一辈子的病”，原因就是细菌一直在。

第三步：处理止痛药。能停的停；不能停的（比如心脏放了支架必须吃阿司匹林），由医生决定换一种对胃温和些的，或者长期配一种抑酸药。

第四步：戒烟，少酒。

第五步：复查。

- 杀菌的，停药四周以后复查呼气试验；
- **胃溃疡的，一定要按医生说的时间复查胃镜**，看它长好没有，必要时再取活检。原因前面说过：少数胃癌，长得就像一个溃疡，吃了抑酸药还会暂时“好转”。只有胃镜下看到它确实长平了，活检也没有问题，才算放心。
- 十二指肠溃疡一般不需要为这个原因复查胃镜。

抑酸药能不能长期吃？很多人听说“拉唑吃久了伤肾、骨折、痴呆”，不敢吃。这些担心大多来自观察研究。后来有一项很大的随机试验来检验：17,598 人随机吃泮托拉唑或安慰剂，跟踪了大约三年。肺炎、骨折、肾病、痴呆、心血管病、癌症、死亡，两组都没有差别；只有肠道感染略多一点（1.4% 对 1.0%）[18]。

编者的理解：该吃的时候放心吃满疗程；不需要的时候也不要常年自己买来吃。长期吃不吃，由医生按出血的风险来定。

12 溃疡的一级预防和二级预防

一级预防（不让溃疡发生）：

- **查出幽门螺杆菌就杀掉，全家一起查。**这是最大的一条。
- **止痛药不乱吃。**头疼脑热、腰酸腿疼，不要把止痛片当家常便饭；不要两种止痛药一起吃；不空腹吃；不就着酒吃。必须长期吃的人，先查细菌，问医生要不要护胃。
- **不吸烟，少喝酒。**
- **给压力找个出口。**睡够觉，按时吃饭。

二级预防（早发现，不让它出血穿孔）：

- 反复上腹痛、半夜疼醒、饿了疼，持续几个星期不好，去做胃镜，不要自己买药压着；
- 长期吃止痛药、阿司匹林的老人，家人留意他的大便颜色、有没有越来越没力气、脸色发白（慢慢出血会贫血）；
- 认得出黑便和呕血（见第 10 章《溃疡最怕的三件事》）。

三级预防（得过溃疡，不让它再来）：杀菌并复查；胃溃疡复查胃镜；以后需要吃止痛药时，告诉医生“我得过溃疡”。

第五部分

胆汁反流性胃炎

13 胆汁反流：一道没关严的门

胆汁是肝脏造的，存在胆囊里，吃了油腻的东西以后排进十二指肠，帮着消化脂肪。它本来**不该出现在胃里**。

胃和十二指肠之间有一道“门”，叫幽门。正常情况下它只许出、不许进。如果这道门关不严，或者胃肠的蠕动方向乱了，胆汁就会倒流回胃里。胆汁里的胆汁酸像洗洁精，能把胃壁上那层保护的黏液溶掉。黏膜直接泡在胆汁和胃酸里，就发炎了。这叫**胆汁反流性胃炎**。

哪些人容易有？

- **做过胃手术的人。**幽门被切掉或改了道，几乎都会有。
- **切过胆囊的人。**胆囊没了，胆汁不再“存着等开饭”，而是不停地滴进肠子，空腹时也有，更容易倒流。秘鲁一项研究看了 408 位做胃镜的人：胆汁反流的总比例是 25.74%；**切过胆囊的人里是 52.11%，是没切过的人的 2.6 倍**；50 岁以上的人也更多[19]。
- **没有做过任何手术的人**也会有，叫“原发性”的，原因多半是胃和十二指肠的蠕动不协调。小何就属于这一种。

先要分清两种情况：

- **胃镜下“看到胆汁”**，非常常见。做胃镜时人恶心、干呕，本身就会把胆汁挤上来。光凭这一句，不能说有病。
- **“胆汁反流性胃炎”**，是指反流确实多、黏膜确实有损伤，人又有相应的症状（上腹烧灼样的疼、胀、恶心、嘴苦、吐黄绿色的苦水）。

所以报告上有“胆汁反流”四个字，第一步不是着急，而是问医生一句：“这是做胃镜时反上来的，还是真的有问题？”

14 胆汁反流会变成癌吗

这是最让人担心的问题。现有的研究是这样的：

一、日本的多中心研究。14 家医院测了 2,283 人胃液里胆汁酸的浓度。胆汁酸浓度最高的那四分之一的人，胃黏膜出现“肠化生”（一种癌前状态）的可能明显更高，不管有没有幽门螺杆菌；萎缩性胃炎则没

有看到增加[20]。

二、中国的多中心研究。5 家医院、1,162 人，按胃镜和活检的结果分成慢性胃炎、癌前病变、胃癌三组来比。结果：胃镜下胆汁反流的程度，是癌前病变和胃癌的独立危险因素，把幽门螺杆菌考虑进去以后仍然如此；同时入选的危险因素还有年龄、饮食习惯和胃癌家族史[21]。

这两项研究说明，**胆汁反流和癌前病变之间，确实有关联。**但也要看到它们的局限：

- 都是**横断面**的研究，同一时间看反流和病变，分不清谁先谁后。胃黏膜已经萎缩、胃酸少了的人，胃的蠕动也会变，胆汁可能更容易反上来。
- 没有研究证明：把胆汁反流治好了，胃癌就少了。
- 和幽门螺杆菌比，它的分量小得多。幽门螺杆菌有十几万人的随机试验，胆汁反流没有。

编者的理解：

- 胆汁反流**不是“癌前病变”**，绝大多数有胆汁反流的人不会得胃癌。
- 它值得当作**多一个“认真一点”的理由**：有幽门螺杆菌的，更要杀干净；已经有萎缩、肠化的，按时复查胃镜；少盐、戒烟。
- 不必因为这四个字睡不着觉。

15 胆汁反流怎样治

先说实话：**胆汁反流性胃炎，至今没有公认的“特效方案”。**一项 2003 年的随机试验在开头就写着：目前没有公认的药物治疗办法[22]。二十年过去，情况没有根本的变化。已有的试验都很小，下面按药的种类说：

一、抑酸药加上能“吸住”胆汁酸的黏膜保护药。

- 中国的一项随机试验：切过胆囊、有胆汁反流性胃炎的病人，分成四组吃 8 周：第一组不吃药；第二组只吃雷贝拉唑，这是一种抑酸药；第三组只吃铝碳酸镁，这是一种能结合胆汁酸的抗酸药；第四组两种一起吃。三个吃药的组症状都减轻了，**两种一起吃的最明显**，也只有这一组测到的反流次数明显减少了。但胃镜下的充血和病理上的炎症，各组之间没有差别[23]。
- 意大利的一项随机试验：60 位切过胆囊、没有幽门螺杆菌的病人，分成三组过 3 个月：一组吃黏膜保护药硫糖铝，一组吃雷贝拉唑，一组不吃药。两种药都能减轻上腹痛、烧心、腹胀[22]。

二、熊去氧胆酸。它是一种“温和”的胆汁酸，吃了以后能把胆汁里伤胃的成分替换掉一部分。

- 1985 年美国的一项小试验：12 位胃手术后胆汁反流性胃炎的病人，先吃一个月安慰剂，再吃一个月熊去氧胆酸。吃安慰剂时症状没变；吃药以后疼痛明显减轻，恶心呕吐几乎消失。但胃黏膜的样子和病理没有变[24]。

- 2024 年韩国的一项大一些的试验：500 多位胃癌切胃以后的病人，随机吃熊去氧胆酸或安慰剂一年。**症状上三组没有差别**；胃镜下，小剂量组在 12 个月时胆汁反流和胃炎少了大约一半[25]。

三、促进胃排空的药。道理上讲得通（让胃往下推得更有力），医生也常用，但编者没有找到像样的随机试验。

四、中成药。一篇汇总了 24 项试验、2,417 位病人的分析认为，中成药或中成药加西药，有效率高于单用西药[26]。但这些试验规模都小，多数没有用安慰剂、没有做盲法，结论只能当作线索。

图 7 胆汁反流性胃炎的办法：证据有多硬



没有公认的特效方案；现有的药主要改善症状

把这些合起来看：

- **现有的药，主要是让人舒服一些，**对胃黏膜本身的改变不大；
- 用哪一种、用多久，要医生看着你的情况试，**没有哪一种对每个人都灵**；
- 症状很重、药物无效的（多见于做过胃手术的人），可以考虑手术改道，那是少数。

自己能做的事（编者整理；这些没有专门的试验，但合乎道理，也没有坏处）：

- **少量多餐，吃七八分饱。**胃撑得越大，门越关不严。
- **少吃油腻。**油多，胆汁就排得多。
- **饭后不马上躺下，**睡前两三个小时不吃东西；夜里反得厉害的，把床头垫高一点。
- **戒烟，少酒。**
- **体重超标的减一减**（肚子大，压力就大）。瘦人不在此列。
- **把压力和睡眠管一管。**胃肠的蠕动听神经的（见第 5 章《胃是有“情绪”的器官》）。
- **有幽门螺杆菌的照样杀菌。**不要因为“我是胆汁反流”就把细菌放在一边。

至于一级预防：除了“胆囊能保的不轻易切”（要不要切，由外科医生按结石和症状判断，不能因为怕反流而拖着该切的不切），原发性的胆汁反流，目前还没有已知的预防办法。

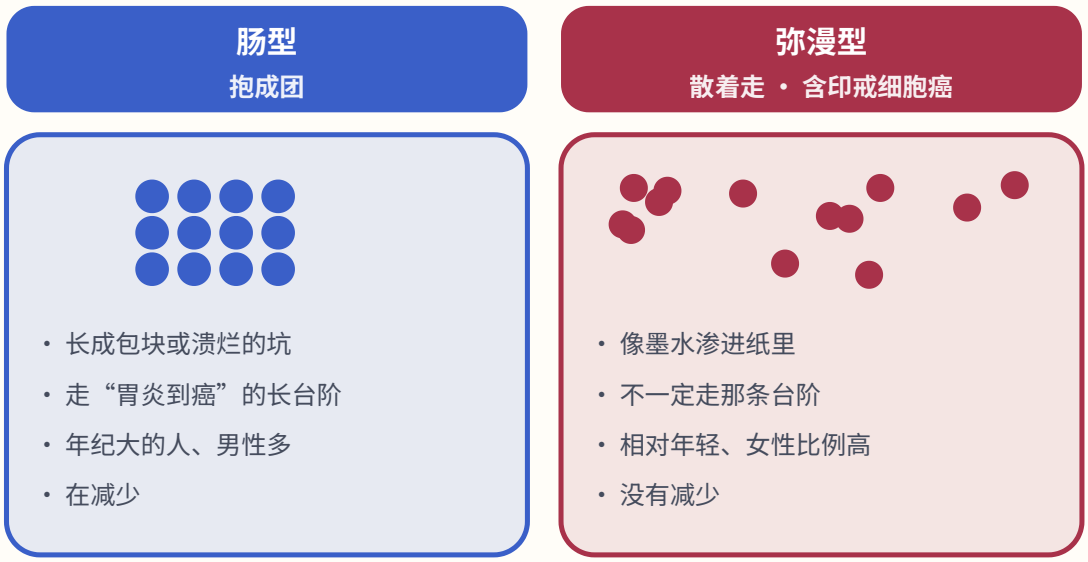
第六部分

胃癌、印戒细胞癌和家族

16 胃癌有两种长法

病理医生在显微镜下看胃癌，很早就发现它有两种很不一样的长法（叫作劳伦分型）：

图 8 胃癌的两种长法



两种都和幽门螺杆菌有关；杀菌对两种都有用

	肠型	弥漫型
癌细胞的样子	排成一根根小管子，抱成团	一个个散开，各走各的
怎么长	先鼓出一个包块或溃烂成一个坑	像墨水渗进纸里，顺着胃壁蔓延
来路	沿着“胃炎、萎缩、肠化、异型增生”的台阶，走几十年	不一定走这条台阶
谁多	年纪大的人，男性	相对年轻的人，女性的比例高一些
趋势	在减少	没有减少，有的地方还在增加

印戒细胞癌是弥漫型里最有名的一种。名字是这么来的：癌细胞里面装满了黏液，把细胞核挤到了一边，在显微镜下看，像一枚带印章的戒指。

为什么要分这两种？因为它们给我们的“机会”不一样：

- **肠型**走的是那条长长的台阶。从幽门螺杆菌胃炎走到癌，常常要几十年，中间有好几级可以被胃镜发现、被拦下来。第 9 篇讲的“杀菌、查胃镜、盯住萎缩和肠化”，主要拦的是它。这些年胃癌总体在减少，减的也主要是它。
- **弥漫型**不一定走台阶，癌细胞散着长，早期在胃镜下可能只是一小片颜色稍淡的地方，更考验做胃镜的医生的眼力。

美国的癌症登记资料显示：1973 到 2000 年，肠型胃癌一直在减少；弥漫型却从每 10 万人 0.3 例升到了 1.8 例，增加的主要就是印戒细胞癌[27]。（这里面有一部分，可能是病理医生分类越来越细造成的。）

不过有一点要说清楚：**幽门螺杆菌对两种类型都是危险因素。**杀菌，对两种都有用。

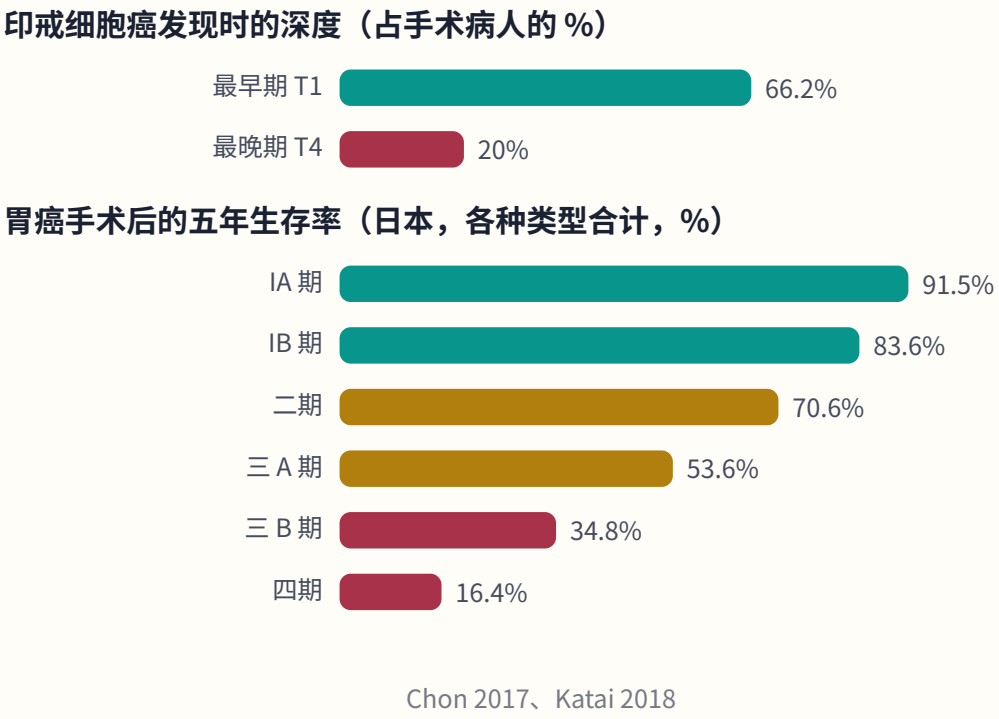
17 印戒细胞癌：早期和晚期，是两回事

网上说印戒细胞癌“恶性程度最高”“年轻人的杀手”。这话只说对了一半。

韩国一家大医院，回顾了 7,667 位做了胃癌根治手术的病人，其中 1,646 位是印戒细胞癌[28]。结果很有意思：

- 印戒细胞癌的病人**更年轻，女性更多**；
- 它被发现的时候，**“两头多”**：66.2% 还在最早的阶段（只在胃壁最里面一两层），20% 已经到了最晚的阶段（穿透了胃壁）；中间的反而少；
- **早期的印戒细胞癌，预后比早期的普通腺癌还要好一些；**
- **进展期的印戒细胞癌，预后比同期的普通腺癌差，**越晚差得越多。

图 9 印戒细胞癌“两头多”；胃癌越早，活得越久



Chon 2017、Katai 2018

一篇综述的说法和这一致：早期的印戒细胞癌，有的可以在内镜下切除，结局比非印戒的好；进展期的一般认为更凶、对化疗不那么敏感，不过学界对此还有争论，有人认为它“预后差”主要是因为发现得晚[29]。

所以，更准确的说法是：**印戒细胞癌不是“天生没救”，而是“特别不能拖”。**它一旦过了早期，顺着胃壁蔓延得快；整个胃壁都被浸透、变硬，叫作“皮革胃”，那时就很难治了。

早期发现以后怎样治？

- 普通的早期胃癌，现在首选在胃镜下把病变那一小片“剥”下来（内镜黏膜下剥离术），不用开刀、不用切胃[30]。
- 印戒细胞癌这类“未分化型”的，因为散着长、淋巴结转移的机会高一些，适合内镜切除的范围**更窄**（要更小、更浅、没有溃疡）。韩国一项 1,147 人的研究里，符合条件的病人做内镜切除，长期生存和手术没有差别；作者强调必须严格挑选病人[31]。
- 不符合条件的，做手术。

它为什么常常发现得晚？一是早期没有症状；二是年轻人觉得“我这么年轻，不会是癌”，胃不舒服就自己买药吃；三是它在胃镜下不显眼。

所以对年轻人，提醒只有一条：**出现“报警症状”，不要因为年轻就不查**（见第 20 章《胃癌的一级预防和二级预防》）。

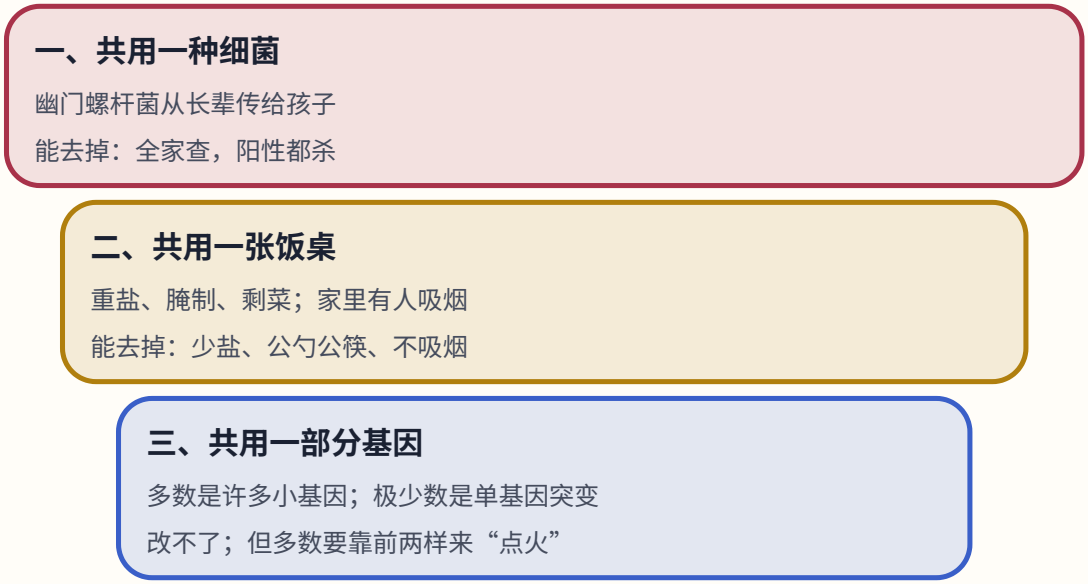
18 爷爷是胃癌，我会不会也得

先给数字：**一级亲属（父母、兄弟姐妹、子女）得过胃癌的人，自己得胃癌的风险确实更高。**各国的研究里，这个风险是没有家族史的人的 2 倍到 10 倍不等，因国家和人群而异[32]。大约 10% 的胃癌病人有家族聚集的现象[33]。

小何的爷爷是二级亲属（隔了一代），风险的升高比一级亲属要小；但他父亲、他自己都感染了幽门螺杆菌，这一家值得认真对待。

为什么胃癌会“扎堆”在一家？有三个原因，按分量从大到小：

图 10 胃癌为什么在一家人里扎堆



有家族史的人杀了菌，约 9 年里胃癌少约 55%

Choi 2020 韩国随机试验 · 分量从上到下递减（编者整理）

一、一家人共用一种细菌。幽门螺杆菌多半是小时候在家里染上的，从长辈传给孩子。爷爷的胃癌，很可能就是这只细菌几十年的结果；而同一只细菌，现在住在儿子和孙子的胃里。

二、一家人共用一张饭桌。口味是从小养成的：咸菜、腌肉、咸鱼、重盐、剩菜，一代传一代。吃盐多的人胃癌风险高约七成[34]；家里有人吸烟，孩子也更容易吸。

三、一家人共用一部分基因。这又分两种：

- 大多数是**许多个作用很小的基因**凑在一起，让这一家人的胃对细菌的炎症反应更重一些。这种“体质”改不了，但它要靠细菌和盐来“点火”。
- 极少数是**单个基因的严重突变**，直接导致胃癌，这就是下一章要讲的遗传性弥漫型胃癌。

好消息在这里：前两个原因是可以去掉的，而且去掉以后效果很大。韩国那项随机试验，找的全是父母或兄弟姐妹得过胃癌、自己又有幽门螺杆菌的人。杀菌组约 9 年后，1.2% 得了胃癌，安慰剂组是 2.7%，**少了约 55%**；真正杀干净的人只有 0.8%，一直感染的人是 2.9%[9]。

也就是说，**家族史不是“判决书”。有家族史的人，恰恰是杀菌获益最大的人。**

有胃癌家族史的人，该做什么（编者整理）：

- **全家都查幽门螺杆菌，阳性的都杀，都复查。**一个人杀了，家里别人还带着，容易再传回来。
- **做一次胃镜，**了解自己胃黏膜的“底子”（有没有萎缩、肠化）。一般建议从 40 岁开始；家里人得病早的，可以提前，和医生商量。以后多久复查一次，看这次的结果。
- **把家里的饭桌换一换：**少盐，少腌制、熏制的东西，多新鲜蔬菜水果；用公勺公筷。
- **不吸烟。**吸烟的男性胃癌风险高约六成[35]。
- **把家人的病史问清楚：**谁得的，多大年纪得的，病理是什么类型（“肠型”还是“弥漫型”“印戒细胞癌”）。这对下一章很重要。

19 真正“遗传”的胃癌：很少见，但要认得

1998 年，新西兰的科学家在一个毛利人大家族里找到了答案。这个家族几代人里，很多人年纪轻轻就死于弥漫型胃癌。研究者发现，他们都带着同一个基因的突变。这个基因叫 CDH1，它负责造一种把细胞和细胞“粘”在一起的蛋白[33]。“胶水”失灵了，细胞就容易散开乱走，这正是弥漫型胃癌的样子。

这种病叫**遗传性弥漫型胃癌**。它的特点[36]：

- 父母一方带有突变，每个孩子有一半的机会遗传到；
- 主要引起两种癌：**弥漫型胃癌（包括印戒细胞癌）**和女性的**乳腺小叶癌**；
- 发病年纪轻。

带了这个突变，一定会得胃癌吗？不一定。早年的估计是一生有五成到八成的机会；后来有研究用不是专门挑“癌症大家族”的 75 个家庭重新算，到 80 岁时得胃癌的机会，**男性约 42%，女性约 33%**；女性得乳腺癌的机会约 55%[37]。仍然很高，但不是百分之百。

查出带有突变怎么办？国际指南的意见是：预防性地把整个胃切掉，仍然是推荐的办法；不愿意马上手术的人，可以在有经验的中心定期做很仔细的胃镜监测[36]。这是非常重大的决定，必须由遗传咨询和专科医生一起来帮着做。

哪些家庭要想到它？下面是国际指南的大意（编者转述，细节以遗传咨询为准）[36]：

- 家里有两个或更多的人得过胃癌，其中至少一个确诊是**弥漫型**；
- 有人在 **50 岁以前**得了弥漫型胃癌；

- 家里既有人得弥漫型胃癌，又有人得乳腺小叶癌。

符合这些情况的家庭，可以到大医院的肿瘤遗传门诊咨询要不要做基因检测。

请注意比例：**这是很少见的病。**绝大多数“家里有人得胃癌”的家庭，原因是上一章讲的细菌和饭桌，不是这个基因。小何的爷爷六十多岁发病，家里只有他一个人得癌，就不像这种情况。

不要因为读了这一章，就自己去网上买基因检测。没有上面这些线索的人，查出来的“意义不明的变异”只会带来没有必要的恐慌。

20 胃癌的一级预防和二级预防

把第 9 篇和这一部分合起来，胃癌的预防可以收成两段话。

一级预防（不让它发生）：

- **杀幽门螺杆菌。**最重要的一条，对肠型、弥漫型都有用，有家族史的人获益最大[9][10]。
- **少盐，少吃腌制、熏制的食物**[34]。
- **不吸烟**[35]，少喝酒。
- **多吃新鲜蔬菜水果**[30]。
- **公勺公筷，不嘴对嘴喂孩子，**不让细菌传给下一代[1]。

二级预防（在早期把它找出来）：

早期胃癌几乎没有症状，所以**不能等症状**，要靠胃镜主动去找。韩国给 40 岁以上的人做全国胃镜筛查，做过筛查的人因胃癌死亡的风险低了约 47%[38]。

早和晚，差别有多大？日本全国 11 万多例胃癌手术的登记资料[39]：

- 最早的一期（IA 期）：五年生存率 **91.5%**；癌只在胃壁最里面一层的，因胃癌死亡的不到 1%；
- 二期：70.6%；
- 三期：53.6% 到 34.8%；
- 四期：16.4%。

在日本，接受手术的病人里 44% 是最早的那一期[39]。这是全国筛查做了几十年的结果。

哪些人该做胃镜（编者整理，和第 9 篇一致）：

- 40 岁以上，又有下面任何一条：幽门螺杆菌感染、一级亲属得过胃癌、长期吃得很咸、吸烟、住在胃癌高发地区；
- 以前查出过萎缩性胃炎、肠化、异型增生，到了复查的时间；

- **不论年纪多大，**出现下面的“报警症状”。

报警症状：不论多年轻，都要尽快做胃镜

- 体重莫名下降（没有刻意减肥，几个月里掉了好几斤）；
- 黑便或呕血；
- 吞咽困难，吃东西发噎；
- 反复呕吐；
- 贫血（脸色白、乏力、心慌）；
- 吃一点就饱，而且越来越明显；
- 上腹持续地疼，吃药两三个星期不见好；
- 上腹摸到包块。

晚期胃癌的治疗这些年也有进步（化疗、靶向药、免疫治疗），但中位生存仍然不到一年[30]。**胃癌这件事，功夫全在前面。**

第七部分

胃镜正常，胃却难受

21 功能性消化不良：胃镜正常，不等于“没病”

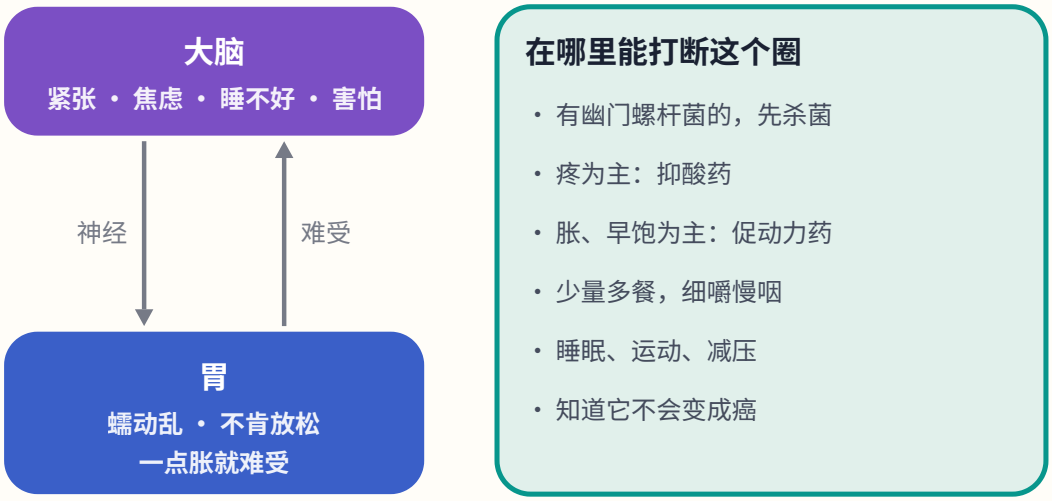
很多人做完胃镜，拿到一张“慢性非萎缩性胃炎”的报告，医生说“没什么事”。可是他明明天天胃胀、吃几口就饱、隐隐地疼。于是他觉得：要么医生没查出来，要么是自己“想多了”。

两样都不是。这种情况有一个正式的名字：**功能性消化不良**。

《柳叶刀》的一篇综述这样概括它[5]：

- 症状是：**上腹痛或烧灼感、饭后饱胀、早饱**（吃一点就饱）；
- 因为这些症状去看病的人，**大约 80% 查不出结构上的原因**，属于功能性消化不良；
- 在普通人群里，多达 16% 的人有；
- 容易得的人：有焦虑或抑郁的、得过一次急性胃肠炎以后的、女性、吸烟的、吃止痛药的、有幽门螺杆菌的；
- 原因还没有完全弄清，多半是**胃肠和大脑之间的通话乱了**：胃的蠕动不协调（排空慢，或者吃了饭胃不肯“放松”来装食物），胃的感觉过敏（正常的一点胀就觉得难受），大脑处理这些信号的方式也变了；
- 它多半是慢性的，时好时坏。

图 11 功能性消化不良：胃和大脑之间的通话乱了



结构是好的，所以胃镜正常；但难受是真的

“慢性非萎缩性胃炎”和症状，其实关系不大。它几乎是成年人胃镜报告上的“标准句”，没有症状的人做胃镜，大多也是这一句。把症状都归到“胃炎”头上，吃很多年“养胃药”，是常见的弯路。

怎样治？按综述的归纳[5]：

- **有幽门螺杆菌的，先杀菌。**大约每治 14 个人，有 1 个人的症状从此完全好了[40]。比例不高，但这是唯一可能“除根”的办法，何况还防癌。
- **抑酸药：**对以上腹痛、烧灼感为主的人较有用。
- **促动力药：**对以饭后胀、早饱为主的人较有用。
- **小剂量的“神经调节药”：**其实就是小剂量的抗抑郁药。用它不是说你有精神病，而是用它来调低胃肠神经的敏感度。常规办法无效时，医生会考虑。
- 心理治疗的作用还不确定。

自己能做的事（编者整理）：

- 少量多餐，细嚼慢咽，不要吃得太快、太撑；
- 找出让自己难受的食物（每个人不一样，常见的是油腻、太辣、太甜、浓茶咖啡、碳酸饮料），先少吃；不必把自己的食谱缩得只剩白粥；
- 规律运动，睡够觉；
- 把压力当回事。很多人的胃，是在工作最紧、家里最乱的那一阵坏的，也是在那一阵过去以后好的。

最要紧的一句话：功能性消化不良**不会变成癌，不会缩短寿命**。明白了这一点，很多人的症状自己就轻了一半，因为“怕”本身就在加重它。

当然，前提是该查的查过了。综述的意见是：典型的症状不必人人做胃镜；55 岁以上，或者有体重下降、呕吐等情况的，才需要[5]。那是西方国家的标准；在胃癌多的中国，医生把这个年龄放得更低（一般 40 岁），有家族史的更要查。

第八部分

吃不胖：瘦人怎样健康增重

22 瘦，算不算问题

在一个人人喊着减肥的年代，“吃不胖”听上去像是炫耀。但真正瘦的人知道那是什么滋味：衣服撑不起来，冬天怕冷，容易累，生一场病就掉好几斤，亲戚见面第一句话是“你怎么又瘦了，是不是胃有毛病”。

先看怎样算“瘦”。通用的尺子是体重指数（英文缩写 BMI）：体重的公斤数，除以身高米数的平方。

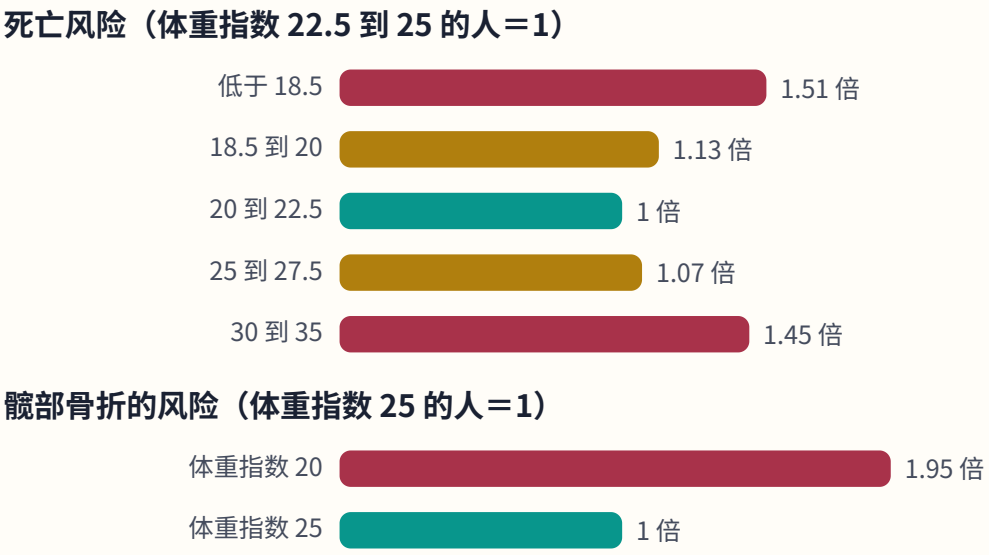
- 18.5 到 24：正常（中国的标准）；
- **低于 18.5：体重过低。**

小何一米七二、五十三公斤，算下来是 17.9，属于轻度的体重过低。

瘦，对健康有影响吗？有三组数字：

- 全球 239 项前瞻研究的汇总，专门挑出从不吸烟、没有慢性病的 395 万人，并且去掉了头五年的死亡（为了排除“因为有病才瘦”）：体重指数在 20 到 25 之间的人死亡风险最低；**18.5 到 20 的人高 13%；低于 18.5 的人高 51%**[41]。
- 中国 22 万男性跟踪 15 年的研究：体重指数和死亡的关系是一条 U 形线，最低点在 22.5 到 25。在偏瘦的一段，多出来的死亡主要来自和吸烟有关的病：慢阻肺占了一半多，还有肺癌、胃癌[42]。
- 12 个国家近 6 万人的汇总：和体重指数 25 的人比，**体重指数 20 的人髋部骨折的风险接近两倍**[43]。

图 12 太瘦和太胖，风险都高一些



Global BMI Mortality Collaboration 2016、De Laet 2005 · 观察研究

这些数字怎样理解才不偏?

- **“瘦的人死亡风险高”，有相当一部分是因为瘦的背后藏着别的事**：还没查出来的病、吸烟、肌肉少、营养不够。研究者尽力排除了，但排不干净。
- **一直瘦、体重稳定、精力好、各项检查正常的人，**风险的升高是很小的，不必吓自己。
- **真正要当回事的是两种情况：**一是**最近变瘦**（没有刻意减，体重却在掉）；二是**瘦而且没有肌肉**，尤其是上了年纪的人。
- 对瘦人，最实在的风险是**骨头和肌肉**：底子薄，老了以后更容易骨质疏松、跌倒、骨折；大病、手术的时候，“储备”少，恢复得慢。

所以，瘦人想增重，是正当的健康目标。只是目标不应该是“长肉”，而应该是**“长力气、长肌肉、长一点储备”**。

23 为什么吃不胖：三种不同的瘦

体重是一本账：吃进去并且吸收了的，减去消耗掉的。长期瘦，无非三种原因。它们的办法完全不同，所以先要分清自己是哪一种。

第一种：有病。或者让人吃不下（胃病、抑郁、肿瘤），或者让人吸收不了（肠道的病、胰腺的病），或者让人消耗太多（甲亢、没控制好的糖尿病、慢性感染）。这一种的特点是：**体重在往下走**，或者伴着别的症状。下一章专门讲。

第二种：其实吃得不够。这是最常见、也最容易被自己否认的一种。很多瘦人真心觉得“我吃得不少”，但认真记几天账就会发现：

- 正餐吃得快、吃得少，七分饱就放筷子；
- 一忙就跳过一顿，或者用一杯咖啡、几块饼干对付；
- 几乎不吃零食，不喝有热量的东西；
- 偶尔“吃得很多”的那一顿，印象特别深，就以为自己天天如此。

背后的原因，常常是胃口小、饱得快、压力大、睡得少，或者胃不舒服所以不敢多吃。

第三种：体质性消瘦。这是近二十年才被认真研究的一类人。法国的研究者这样描述他们[44][45]：

- 从小就瘦，体重多年稳定在偏低的水平；
- 没有进食障碍，不怕胖，**反而想长胖**；
- 没有营养不良的迹象，化验基本正常，女性月经正常；
- 家里常常有同样瘦的人；
- **想胖也胖不起来**。

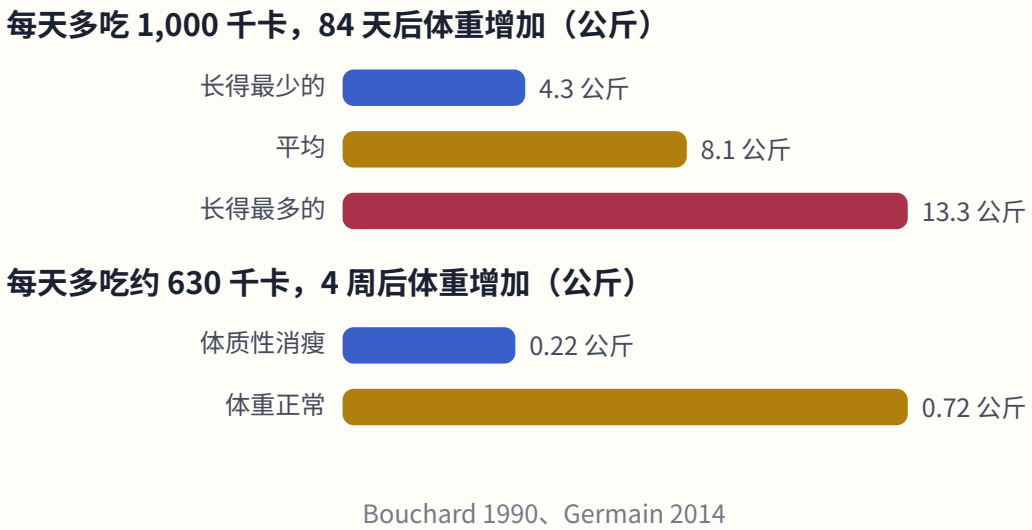
他们“胖不起来”，不是错觉。研究者请 8 位体质性消瘦的女性和 8 位体重正常的女性，都在平时的饭量以外，每天多吃大约 630 千卡的脂肪，连吃 4 周[46]：

- 体重正常的人平均重了 0.72 公斤；
- **体质性消瘦的人只重了 0.22 公斤，统计上等于没变；**
- 她们的身体做了两件事来“抵抗”：静息时消耗的能量增加了；饭后让人觉得饱的激素升得更早、更高，让人觉得饿的激素更低。

更早的两项经典研究，也说明人和人差别有多大：

- 加拿大的研究者让 12 对同卵双胞胎每天多吃 1,000 千卡，吃了 84 天。平均重了 8.1 公斤，但**最少的只重了 4.3 公斤，最多的重了 13.3 公斤**。同一对双胞胎之间很像，不同的双胞胎之间差得远。这说明起作用的主要是基因[47]。
- 美国的研究者让 16 个人每天多吃 1,000 千卡，吃了 8 周，同时精确测量能量去了哪里。结果：有的人几乎都存成了脂肪，有的人存得很少，相差十倍。差别主要来自一种“不算运动的活动”：坐不住、走来走去、小动作多、站着比坐着多。多吃以后，有的人不知不觉动得更多，把热量散掉了[48]。

图 13 同样多吃，人和人差得很远



Bouchard 1990、Germain 2014

遗传学的研究也支持这一点：健康的瘦，和重度肥胖一样，有相当一部分是遗传决定的[49]。

那么“吸收不好”呢？这是瘦人最常给自己下的诊断，但**多半不对**。真正的吸收不良是一种病，它有自己的表现：

- 长期拉肚子，大便量多、不成形；
- 大便发油、发亮、特别臭，浮在水面上冲不下去（脂肪没吸收）；
- 肚子胀、排气多；
- 贫血，缺铁、缺维生素，嘴角烂、舌头疼，手脚麻，夜里看不清。

没有这些表现、大便正常的瘦人，肠子的吸收一般没有问题。**体质性消瘦的人不是吸收得少，而是消耗得多、饱得快。**

编者的理解：很多“吃不胖”的人，是第二种和第三种的混合：天生饱得快、消耗偏高，加上生活忙、吃得随便。这不是谁的错，但它决定了增重的办法：**不能靠“想起来就多吃两口”，要有一套不依赖胃口的安排。**

24 先排除疾病：哪些情况要去查

在动手增重以前，先确认自己不是第一种。尤其是下面这些情况，**不要自己调理，先去医院**：

这些“瘦”要先看医生

- **以前不瘦，最近几个月没有刻意减，体重却明显在掉；**
- 瘦，同时有上一部分说的“报警症状”：黑便、吞咽困难、反复呕吐、贫血、吃一点就饱而且越来越明显；
- 瘦，同时**吃得多、心慌、怕热、手抖**（要查甲状腺）；
- 瘦，同时**口渴、尿多、总是饿**（要查血糖）；
- 瘦，同时**长期拉肚子、肚子疼、大便带血或发油**（要查肠道）；
- 瘦，同时**长期低烧、夜里出汗、咳嗽**（要查肺和感染）；
- 瘦，同时**情绪低落、对什么都没兴趣、睡不好**，或者很怕胖、吃了就想吐掉；
- 年轻女性瘦到月经不来了。

即使没有上面这些，一个长期体重过低的人，**值得做一次基本的检查**，花钱不多，图个心里有底。常查的项目有（编者参考家庭医生的检查清单[50]整理，具体由医生定）：

- 血常规（看有没有贫血），肝肾功能，空腹血糖；
- **甲状腺功能**（见本站健康栏目第 14 篇《甲状腺》）；
- 铁蛋白、维生素 B12；
- **幽门螺杆菌呼气试验**；
- 大便常规和潜血；
- 胸片；
- 有胃肠症状、有家族史或到了年龄的，做胃镜；长期拉肚子的，做肠镜。

这些都正常，体重又是多年稳定的，那就可以放心：**你是健康的瘦人。**接下来的问题只是“想不想、怎样”长一点。

老人变瘦，要格外当回事。65 岁以上的老人，没有刻意减却瘦了下来，和生病、死亡的风险增加有关。原因里，不是肿瘤的更多（牙不好、吞咽不好、药物让人没胃口、抑郁、孤独、没人做饭），但肿瘤也占到三分之一；还有一部分查不出原因[50]。家里的老人“这半年瘦了不少”，不要只说一句“千金难买老来瘦”，带他去查一查。

25 胃不好和吃不胖，有没有关系

有关系，但不是多数人以为的那种“胃不吸收”。**胃几乎不负责吸收营养，**吸收主要在小肠。胃不好让人瘦，走的是另外几条路：

- **饱得快。**功能性消化不良的人，胃吃了饭不肯放松，装一点就胀（见第 21 章《功能性消化不良：胃镜正常，不等于“没病”》）。每顿少吃几口，一年下来就是好几公斤。
- **不敢吃。**吃了就疼、就胀、就反酸的人，会不自觉地少吃、挑着吃，把食谱越缩越窄。
- **没胃口。**胃里总是不舒服，人对吃饭就没了兴致。
- **溃疡和肿瘤**，当然更会让人瘦，那是另一回事，前面讲过。

杀掉幽门螺杆菌，人会不会胖一点？英国有一项随机试验正好回答了这个问题：1,558 位幽门螺杆菌阳性的普通人，随机吃杀菌药或安慰剂。6 个月后，杀菌组的体重比安慰剂组多长了 0.6 公斤；体重增加 3 公斤以上的人，杀菌组有 19%，安慰剂组 13%；有消化不良症状的人也少了（23% 对 29%）。作者认为，体重增加可能是因为消化不良好了、吃得下了[51]。

0.6 公斤不算多，但对瘦人是个好消息：**把胃治舒服了，本身就是增重的第一步。**

所以像小何这样“胃不好又吃不胖”的人，顺序应该是：

1. 把幽门螺杆菌杀干净，复查；
2. 把功能性的症状（胀、早饱）和胆汁反流的症状，请医生用药调一调；
3. 胃舒服一些以后，再按下一章的办法安排吃和练。

26 怎样增重：七条办法

先说老实话：**关于“健康的瘦人怎样增重”，专门的随机试验很少。**医学界把绝大部分力气花在了减重上。下面的办法，一部分有相邻领域的研究支持（会注明），一部分是营养师常用的做法（编者整理）。

图 14 瘦人增重的七条办法



先排除疾病、把胃治舒服，再开始 · 编者整理

一、目标定小一点，时间放长一点。

每天比平时多吃三五百千卡，大约就是多一杯奶加一把坚果，或者多一个馒头夹鸡蛋。一个月长半公斤到一公斤，就是很好的速度。到底需要多大的“盈余”，科学上其实还没有定论[52]；这个数只是一个好记的起点。

不要指望一个月长十斤。上一章说过，身体会“抵抗”；慢慢来，反而留得住。

二、加餐，不是加量。

饱得快的人，硬把一顿饭撑大是做不到的，还会胀得下一顿吃不下。办法是把一天分成**三顿正餐加两三次加餐**：上午、下午、睡前各一次。每次不多，加起来就多了。

到点就吃，不等饿。体质性消瘦的人饱的信号强、饿的信号弱[46]，等饿了再吃，永远吃不够。把加餐写进日程，像吃药一样。

三、把一部分热量“喝”进去。

这是最有研究依据的一条。有一项巧妙的试验：让同一批人每天多摄入 450 千卡的糖，一段时间是吃下去（软糖），一段时间是喝下去（汽水），各 4 周。吃软糖的那几周，人们不知不觉在别的地方少吃了，总热量没有增加；**喝汽水的那几周，别处一点没少吃，总热量净增，体重也只在这几周增加了**[53]。

这项研究本来是用来解释“为什么甜饮料让人发胖”的。对瘦人，同一个道理可以反过来用：**液体的热量不太占“饱”的名额。**当然不是叫人去喝汽水，而是：

- 加餐时喝牛奶、酸奶、豆浆、五谷豆浆、米糊；
- 自己打“奶昔”：牛奶或豆浆，加一根香蕉、一勺花生酱或一把坚果、几勺燕麦；
- 饭后喝汤可以，**饭前不要先喝一大碗汤或水**，那会占掉胃的地方。

喝牛奶肚子胀、拉肚子的人，多半是乳糖不耐受。全世界大约三分之二的成年人对乳糖吸收不好[54]，在中国很常见。换成酸奶、无乳糖牛奶或豆浆就行。

四、挑“个头小、热量足”的好食物。

同样一小碗，热量可以差好几倍。瘦人要学着往饭里“加料”：

- **坚果和种子：**核桃、花生、杏仁、芝麻、葵花籽，或者花生酱、芝麻酱。一小把就有一两百千卡。
- **好的油：**菜出锅以后淋一勺橄榄油、香油、亚麻籽油；拌面、拌饭、拌凉菜。
- **豆制品：**豆腐、豆干、腐竹、黄豆。
- **蛋和奶：**每天一两个鸡蛋；全脂的奶和酸奶。
- **主食别怕：**米饭、馒头、面条、红薯、土豆、玉米、燕麦，每顿吃够；粥太稀就不顶用，煮稠一点，或者加红豆、花生、红枣。
- **水果干和牛油果、香蕉**这类热量高一些的水果。

五、每一顿都有蛋白质。

长肌肉要原料。汇总 49 项试验的分析发现：做力量训练的人，蛋白质吃到每公斤体重每天 1.6 克左右，肌肉长得最多；再往上加，没有更多的好处[55]。五十多公斤的人，大约是每天八九十克蛋白质：三顿饭每顿有一掌心大的豆腐、鱼、蛋或肉，再加两杯奶或豆浆，就差不多了。

蛋白粉不是必需的。同一项分析里，额外补蛋白带来的肌肉增加，平均只有 0.3 公斤[55]。饭里吃得够，就不用买；实在吃不够，把它当作一种方便的加餐，可以。

六、练力量，这是把“吃进去的”变成“肌肉”的开关。

只吃不练，多出来的热量要么被身体散掉，要么长成肚子上的脂肪。力量训练是告诉身体：“这些原料，请用来造肌肉。”

- 汇总 111 项研究的分析：健康男性做力量训练，肌肉量平均增加约 1.5 公斤；每次练的组数太多，反而不利[56]。

- 怎样练（编者整理）：每周两三次，每次三四十分钟。练大肌肉群：深蹲，俯卧撑（做不了就跪着做），用弹力带或哑铃做划船，臀桥或硬拉，把重物举过头顶。每个动作做到“再做两三个就做不动”的程度，做两三组。没有器械，用自己的体重和一根弹力带就能开始。
- **练完一小时内吃一次加餐。**
- 长跑、长时间的有氧运动，消耗很大。喜欢的不必停，但在增重的这几个月，可以减一些量。

七、睡够觉，少熬夜，把压力降下来。肌肉是在睡觉的时候长的；压力大、睡得少的人，胃口和消化都差。

最后，**每周固定一个早晨称一次体重，**记下来。两三个星期没有变化，就每天再加一次加餐；长得太快、肚子先大了，就把加餐里的油和糖减一点，把练的加一点。

27 一天怎样安排：给胃不好的瘦人

把上一章的办法摆进一天里，大致是这样（编者整理的示例，不是处方；按自己的口味和忌口换着来）：

时间	吃什么	要点
早餐	稠燕麦粥或杂粮粥加一勺花生酱或芝麻酱；一个鸡蛋；一个馒头或一片面包	不空着肚子出门，不用咖啡顶一顿
上午加餐	一杯酸奶或豆浆，一小把坚果	到点就吃，不等饿
午餐	米饭一碗半；豆腐或鱼或瘦肉；两样蔬菜，出锅淋一勺油	先吃饭和菜，汤放最后
下午加餐	自己打的奶昔（奶或豆浆加香蕉、燕麦、坚果），或者红薯、玉米、包子	力量训练放在这前后最好
晚餐	和午餐相仿，七八分饱	不要太晚、太油，免得夜里反流
睡前一两个小时	一杯温热的奶或豆浆，两块全麦饼干	有胆汁反流、夜里反酸的人，这一顿提前或省掉

胃不好的人，有几处要特别照顾：

- **油要分散着吃。**一顿吃很多油，胆汁排得多，胃排空也慢，容易胀、容易反流。每顿一点，比一顿油腻的大餐好。
- **吃慢一点。**一口饭嚼二十下，一顿饭吃够二十分钟。
- **正在杀菌的两个星期，不必勉强增重。**那两周能正常吃饭就好，等停药、胃口回来再开始。
- **哪样东西吃了难受，就换一样，**不要硬撑，也不要因此把这一类全都戒掉。

耶稣讲过一段话，瘦人和胃不好的人读起来，也许别有体会：

> 25 所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？ 26 你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重得多吗？
>
> 马太福音 6:25—26

这段话不是叫人不管吃喝。它说的是：**不必带着忧虑去吃。**为每一口饭提心吊胆的人，胃是放松不下来的。把该查的查了，该治的治了，然后安安心心、按时按点地吃饭，这本身就是对胃最好的照顾。

28 为什么胖了两斤，又掉回去

小何有过这样的经历：有一阵吃得好，重了五六斤；后来一忙，一两个月又回到原来的数字。很多瘦人都有同感，好像身体里有一根弹簧。

这根“弹簧”是真的。前面的研究已经说明了它是什么[46][48]：

- 多吃以后，有的人的身体会**自动多消耗**：静息代谢升高，小动作变多；
- 同时**自动少吃**：饱的信号更强，下一顿不知不觉吃得更少。

所以，只要“额外的那几口”是靠意志力硬加的，意志力一松（忙了、病了、心情不好），体重就回去了。

对付这根弹簧，有三点（编者的理解）：

- **把加餐变成习惯，而不是“任务”。**固定的时间、固定的几样东西、放在伸手就够得着的地方。不用想，到点就吃。
- **让长出来的是肌肉。**脂肪是身体“不想要就能很快烧掉”的；肌肉只要还在用，身体就会留着它。坚持练力量的人，体重更留得住。
- **用半年、一年的眼光看。**先长两三公斤，稳住三个月；再长两三公斤。忙的时候体重掉一点没关系，只要加餐和训练的习惯还在，它会回来。

也要**接受自己的体质**。一个天生骨架小、消耗高的人，目标不必是变成“壮汉”。把体重指数从十七八带到十九、二十，胳膊腿上有肌肉，爬楼不喘，冬天不那么怕冷，生病了扛得住，就是成功。

不要做的事：

- **不靠垃圾食品硬塞。**炸鸡、奶茶、蛋糕、方便面确实长体重，但长的是肚子上的脂肪和血脂，瘦人一样会得脂肪肝、高血脂。
- **不买“增肥药”“开胃药”“增重粉”。**来路不明的增肥产品，有的掺了激素，吃了会浮肿、发胖、长痘、血糖升高，停了更糟。老年医学的指南也不建议给消瘦的老人用开胃药[50]。

- **不拿别人比。**同样多吃一千千卡，有人长四公斤，有人长十三公斤[47]。你的进度只和你自己上个月比。

第九部分

预防总表与结语

29 一张总表：每一样怎样防、怎样查、怎样治

把全篇收进一张表。**一级预防**是不让它发生；**二级预防**是早发现、不让它造成损害；**治疗**是已经有了怎么办。

图 15 护胃的三级预防

一级预防：不让它发生

- 全家查幽门螺杆菌，阳性都杀
- 少盐、少腌制；公勺公筷
- 不吸烟，少喝酒
- 止痛药不乱吃

二级预防：早发现

- 40 岁以上有危险因素的，做一次胃镜
- 报警症状马上查：黑便、消瘦、吞咽困难、贫血
- 胃溃疡复查胃镜；萎缩、肠化按时复查
- 最近变瘦的，先查原因

治疗：不半途而废

- 杀菌吃满疗程，停药四周后复查
- 溃疡的抑酸药吃满疗程
- 功能性的：按症状用药，少量多餐
- 瘦人：加餐、蛋白质、力量训练，慢慢来

编者根据本篇引用的研究整理

哪一样	一级预防	二级预防	治疗
幽门螺杆菌	公勺公筷；不嘴对嘴喂孩子	成年人查一次呼气试验；家人一起查	四联或二联，吃满疗程；停药四周后复查
溃疡	杀菌；止痛药不乱吃；不吸烟	反复上腹痛做胃镜；认得出黑便	抑酸药吃满疗程，杀菌；胃溃疡复查胃镜
胆汁反流	没有明确的办法；胆囊不轻易切	有萎缩、肠化的按时复查胃镜	抑酸药加黏膜保护药等，因人而异；少量多餐、少油
胃癌	杀菌；少盐少腌制；不吸烟；多蔬果	40 岁以上有危险因素的做胃镜；报警症状马上查	早期在胃镜下切除；越早越好
功能性消化不良	规律吃饭，睡眠，减压	查过胃镜、排除了别的就放心	杀菌；按症状选药；少量多餐
体重过低	从小吃好三餐，多活动，长好肌肉和骨头	最近变瘦的要查原因	先治病；加餐、喝进去的热量、蛋白质、力量训练

如果只记五条：

1. **全家查幽门螺杆菌，阳性的杀干净、要复查。**这一条同时防胃炎、防溃疡、防胃癌。
2. **饭桌上少盐、少腌制，用公勺公筷；不吸烟。**
3. **止痛药不乱吃。**
4. **该做胃镜的时候做胃镜：**40 岁以上有危险因素的，有报警症状的，胃溃疡复查的。
5. **瘦人先排除疾病，再用“加餐、喝的热量、蛋白质、力量训练”慢慢长。**

30 常见的问题

胃镜报告写“慢性非萎缩性胃炎”，要不要紧？

多半不要紧。它几乎是成年人胃镜报告上的常见用语，本身不是癌前病变。要紧的是三件事：有没有幽门螺杆菌，有没有萎缩和肠化，有没有异型增生。胃不舒服但胃镜只有这一句的，多数属于功能性消化不良[5]。

我没有任何不舒服，会不会有溃疡？

有可能。上海居民的胃镜调查里，有溃疡的人七成多没有症状[2]。长期吃阿司匹林或止痛药的人、幽门螺杆菌阳性的人，更要留意黑便、贫血这些信号。

溃疡好了以后，还会再犯吗？

如果是幽门螺杆菌引起的，杀了菌就很少再犯：十二指肠溃疡一年内复发从约 64% 降到约 13%，胃溃疡从约 52% 降到约 16%[14]。没杀菌、或者继续吃止痛药的，容易再犯。

“拉唑”类的抑酸药能长期吃吗？

需要的时候可以。一项 1.7 万人、约三年的随机试验里，除了肠道感染略多，肺炎、骨折、肾病、痴呆、死亡等都和安慰剂没有差别[18]。但不需要的时候不要常年自己买来吃，由医生定。

胆汁反流会变成胃癌吗？

绝大多数不会。研究看到它和肠化生等癌前病变有关联[20][21]，但这些是横断面研究，分不清因果，也没有证据说治好了反流就能防癌。有幽门螺杆菌的要杀菌，有萎缩、肠化的按时复查胃镜。

益生菌能不能代替四联杀菌？

不能。单吃益生菌，只有大约 14% 的人能清除幽门螺杆菌[13]。四联受不了，可以请医生换成副作用少一些的二联[12]。胃舒服了不等于细菌没了，要以复查的呼气试验为准。

家里有人得胃癌，我一定也会得吗？

不一定。一级亲属得过胃癌的人，风险是别人的两倍以上[32]，但主要原因是一家人共同的幽门螺杆菌和饮食习惯。有家族史的人杀菌以后，胃癌少了约 55%[9]。

印戒细胞癌是不是一发现就是晚期？

不是。韩国 1,646 例手术病人里，三分之二发现时还在早期，而早期印戒细胞癌的预后并不比别的类型差[28]。它的问题是过了早期进展快，所以有报警症状的年轻人不要因为年轻就不查。

我吃得不少却不胖，是不是吸收不好？

多半不是。真正的吸收不良会有长期腹泻、大便发油、贫血等表现。体重多年稳定、检查正常的瘦人，更常见的原因是体质（饱得快、消耗高）加上实际吃得不够[46][45]。

瘦人要不要喝蛋白粉? −

不是必需的。做力量训练的人额外补蛋白，肌肉平均只多长 0.3 公斤；蛋白质吃到每公斤体重每天约 1.6 克以后，再多也没有更多好处[55]。饭里吃够豆、蛋、奶、鱼、肉就行，吃不够时把它当一次方便的加餐。

杀了幽门螺杆菌，人会胖一点吗? −

可能会一点。英国的随机试验里，杀菌组 6 个月后比安慰剂组多长了 0.6 公斤，消化不良的症状也少了[51]。对胃不舒服、吃不下的瘦人，把胃治好是增重的第一步。

老人越来越瘦，是不是“千金难买老来瘦”? −

不是。老人没有刻意减却瘦下来，要查原因：牙口、吞咽、药物、情绪、孤独都可能，肿瘤也占到三分之一[50]。偏瘦的老人髋部骨折的风险也高得多[43]。

31 结语：小何后来

小何带着那张没吃完的药单，回去找了医生。

医生听他说了嘴苦、恶心，又问了他爷爷的事，说：“你这种情况，这次一定要杀成功。四联受不了，我们换二联，只有两种药，副作用少很多。”又加了一句：“让你父母也来吹个气。”

两个星期的药，他这次吃完了。停药一个月以后复查，阴性。他父亲查出来是阳性，母亲也是；两位老人一起吃了药，也都转阴了。父亲这才知道，自己年轻时那场溃疡出血，和儿子胃里的细菌，原来是同一回事。

家里的饭桌也变了一点：咸菜坛子还在，但不再顿顿上桌；每个菜多了一把公勺。

关于印戒细胞癌，医生的话让他放了心：“你爷爷六十多岁发病，家里就他一个，这不像遗传的那种。你现在三十四岁，胃黏膜没有萎缩，细菌也杀了。四十岁的时候再来做一次胃镜就行。”

关于胆汁反流，医生给他开了一个多月的药，嘱咐他少量多餐、晚饭别太晚。饭后那种烧灼的感觉，慢慢少了。

然后是体重。检查都正常，甲状腺也正常，他终于承认自己是“健康的瘦人”，而且以前其实吃得并不够。他给自己定了三条：上午十点一杯酸奶加一把坚果，下午四点一杯自己打的奶昔，每周二、四、六晚上在家练半小时力量。

头一个月，体重只动了半公斤，他有点泄气。第三个月，重了两公斤半，俯卧撑从做五个变成能做二十个。年底回家，奶奶摸着他的胳膊说：“这回是真结实了。”

这一篇想说的就是这些：**“胃不好”可以一样一样分清；家里的胃癌可以在自己这一代拦住；瘦人也可以一点一点长出力气。**都不是一夜之间的事，但每一样，都有路可走。

使徒约翰给朋友写信，开头是这样一句问候：

> 亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。
>
> 约翰三书 2

愿你和家人的胃，吃得下，消化得了；也愿你们的心，像身体一样安稳。

这一篇是健康科普，不能代替医生的诊断和处方。药怎样吃、要不要做胃镜、体重下降是什么原因，请和你的医生商量。

读完了？把这一篇分享给需要的人，或者答 3 道小题，下载 PDF 留着慢慢读。

资料出处

本页引用的医学研究和指南，都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，附 DOI 或 PubMed 链接；本页只转述摘要和指南里的结论，数字以原文为准。外文引文的中文都是编者所译。经文用和合本。

资料在 2026 年 11 月逐一核对过；部分外国网站在中国大陆可能打不开。点 ↑ 回到正文引用的位置。

1. 学术研究 Zhou XZ, et al. Large-scale, national, family-based epidemiological study on Helicobacter pylori infection in China: the time to change practice for related disease prevention. Gut 2023;72(5):855-869（2021 年 29 省 10,735 个家庭 31,098 人；PubMed 36690433） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
2. 学术研究 Li Z, et al. Epidemiology of peptic ulcer disease: endoscopic results of the systematic investigation of gastrointestinal disease in China. Am J Gastroenterol 2010;105(12):2570-2577（上海居民随机抽样；PubMed 20736940） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
3. 学术研究 Lanas A, Chan FKL. Peptic ulcer disease. Lancet 2017;390(10094):613-624（综述；PubMed 28242110） doi.org ↗ ↑
4. 学术研究 Sung JJY, Kuipers EJ, El-Serag HB. Systematic review: the global incidence and prevalence of peptic ulcer disease. Aliment Pharmacol Ther 2009;29(9):938-946（PubMed 19220208） doi.org ↗ ↑

5. 学术研究 Ford AC, et al. Functional dyspepsia. Lancet 2020;396(10263):1689-1702（综述；PubMed 33049222） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

6. 学术研究 Han B, et al. Cancer incidence and mortality in China, 2022. J Natl Cancer Cent 2024;4(1):47-53（国家癌症中心；PubMed 39036382） doi.org ↗ ↑ ↑

7. 学术研究 Pan KF, et al. Gastric cancer prevention by community eradication of Helicobacter pylori: a cluster-randomized controlled trial. Nat Med 2024;30(11):3250-3260（山东临朐 980 村 180,284 人，随访 11.8 年；PubMed 39079993） doi.org ↗ ↑

8. 学术研究 Li WQ, et al. Effects of Helicobacter pylori treatment and vitamin and garlic supplementation on gastric cancer incidence and mortality: follow-up of a randomized intervention trial. BMJ 2019;366:l5016（山东干预试验 3,365 人，22 年；PubMed 31511230） doi.org ↗ ↑

9. 学术研究 Choi IJ, et al. Family History of Gastric Cancer and Helicobacter pylori Treatment. N Engl J Med 2020;382(5):427-436（1,838 人，随访 9.2 年；PubMed 31995688） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

10. 学术研究 Lee YC, et al. Association Between Helicobacter pylori Eradication and Gastric Cancer Incidence: A Systematic Review and Meta-analysis. Gastroenterology 2016;150(5):1113-1124（24 项研究 48,064 人；PubMed 26836587） doi.org ↗ ↑ ↑

11. 学术研究 Zhou L, et al. 2022 Chinese national clinical practice guideline on Helicobacter pylori eradication treatment. Chin Med J 2022;135(24):2899-2910（PubMed 36579940） doi.org ↗ ↑

12. 学术研究 Cheung KS, et al. Vonoprazan Dual or Triple Therapy Versus Bismuth-Quadruple Therapy as First-Line Therapy for Helicobacter pylori Infection: A Three-Arm, Randomized Clinical Trial. Helicobacter 2024;29(5):e13133（深圳 298 人；PubMed 39244723） doi.org ↗ ↑ ↑

13. 学术研究 Losurdo G, et al. Probiotic monotherapy and Helicobacter pylori eradication: A systematic review with pooled-data analysis. World J Gastroenterol 2018;24(1):139-149（PubMed 29358890） doi.org ↗ ↑ ↑

14. 学术研究 Ford AC, et al. Eradication therapy for peptic ulcer disease in Helicobacter pylori-positive people. Cochrane Database Syst Rev 2016;4:CD003840（考克兰综述，55 项试验；PubMed 27092708） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

15. 学术研究 Huang JQ, Sridhar S, Hunt RH. Role of Helicobacter pylori infection and non-steroidal anti-inflammatory drugs in peptic-ulcer disease: a meta-analysis. Lancet 2002;359(9300):14-22（PubMed 11809181） doi.org ↗ ↑

16. 学术研究 Levenstein S, et al. Psychological stress increases risk for peptic ulcer, regardless of Helicobacter pylori infection or use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Clin Gastroenterol Hepatol 2015;13(3):498-506（PubMed 25111233） doi.org ↗ ↑ ↑

17. 学术研究 Hawkey C, et al. Helicobacter pylori eradication for primary prevention of peptic ulcer bleeding in older patients prescribed aspirin in primary care (HEAT): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2022;400(10363):1597-1606（PubMed 36335970） doi.org ↗ ↑ ↑

18. 学术研究 Moayyedi P, et al. Safety of Proton Pump Inhibitors Based on a Large, Multi-Year, Randomized Trial of Patients Receiving Rivaroxaban or Aspirin. Gastroenterology

2019;157(3):682-691（试验由药厂资助；PubMed 31152740） doi.org ↗ ↑ ↑

19. 官方网站 Chávez-Mendoza E, et al. Cholecystectomy as a risk factor for duodenogastric reflux. Rev Gastroenterol Peru 2023;43(4):334-340（PubMed 38228299） pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ↗ ↑

20. 学术研究 Matsuhisa T, et al. Relation between bile acid reflux into the stomach and the risk of atrophic gastritis and intestinal metaplasia: a multicenter study of 2283 cases. Dig Endosc 2013;25(5):519-525（PubMed 23363381） doi.org ↗ ↑ ↑

21. 学术研究 Zhang LY, et al. Bile reflux is an independent risk factor for precancerous gastric lesions and gastric cancer: An observational cross-sectional study. J Dig Dis 2021;22(5):282-290（中国 5 个中心；PubMed 33793080） doi.org ↗ ↑ ↑

22. 学术研究 Santarelli L, et al. Post-cholecystectomy alkaline reactive gastritis: a randomized trial comparing sucralfate versus rabeprazole or no treatment. Eur J Gastroenterol Hepatol 2003;15(9):975-979（PubMed 12923369） doi.org ↗ ↑ ↑

23. 学术研究 Chen H, et al. Rabeprazole combined with hydrotalcite is effective for patients with bile reflux gastritis after cholecystectomy. Can J Gastroenterol 2010;24(3):197-201（PubMed 20352149） doi.org ↗ ↑

24. 学术研究 Stefaniwsky AB, et al. Ursodeoxycholic acid treatment of bile reflux gastritis. Gastroenterology 1985;89(5):1000-1004（PubMed 4043659） doi.org ↗ ↑

25. 学术研究 Jang DK, et al. Efficacy of ursodeoxycholic acid for bile reflux after distal gastrectomy in patients with gastric cancer: a secondary analysis of the PEGASUS-D randomized clinical trial. Int J Surg 2024;110(12):7824-7831（PubMed 39422533） doi.org ↗ ↑

26. 学术研究 He M, et al. Traditional Chinese patent medicine for bile reflux gastritis: a systematic review and network meta-analysis. Ann Palliat Med 2021;10(7):7721-7735（PubMed 34353060） doi.org ↗ ↑

27. 学术研究 Henson DE, et al. Differential trends in the intestinal and diffuse types of gastric carcinoma in the United States, 1973-2000: increase in the signet ring cell type. Arch Pathol Lab Med 2004;128(7):765-770（PubMed 15214826） doi.org ↗ ↑

28. 学术研究 Chon HJ, et al. Differential Prognostic Implications of Gastric Signet Ring Cell Carcinoma: Stage Adjusted Analysis From a Single High-volume Center in Asia. Ann Surg 2017;265(5):946-953（韩国 7,667 例手术；PubMed 27232252） doi.org ↗ ↑ ↑

29. 学术研究 Pernot S, et al. Signet-ring cell carcinoma of the stomach: Impact on prognosis and specific therapeutic challenge. World J Gastroenterol 2015;21(40):11428-11438（综述；PubMed 26523107） doi.org ↗ ↑

30. 学术研究 Smyth EC, et al. Gastric cancer. Lancet 2020;396(10251):635-648（综述；PubMed 32861308） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

31. 学术研究 Lim JH, et al. Long-term clinical outcomes of endoscopic vs. surgical resection for early gastric cancer with undifferentiated histology. Surg Endosc 2019;33(11):3589-3599（PubMed 30604260） doi.org ↗ ↑

32. 学术研究 Yaghoobi M, Bijarchi R, Narod SA. Family history and the risk of gastric cancer. Br J Cancer 2010;102(2):237-242（PubMed 19888225） doi.org ↗ ↑ ↑

33. 学术研究 Guilford P, et al. E-cadherin germline mutations in familial gastric cancer. Nature 1998;392(6674):402-405（PubMed 9537325） doi.org ↗ ↑ ↑

34. 学术研究 D'Elia L, et al. Habitual salt intake and risk of gastric cancer: a meta-analysis of prospective studies. Clin Nutr 2012;31(4):489-498（7 项研究 26.9 万人；PubMed 22296873） doi.org ↗ ↑ ↑

35. 学术研究 Ladeiras-Lopes R, et al. Smoking and gastric cancer: systematic review and meta-analysis of cohort studies. Cancer Causes Control 2008;19(7):689-701（PubMed 18293090） doi.org ↗ ↑ ↑

36. 学术研究 Blair VR, et al. Hereditary diffuse gastric cancer: updated clinical practice guidelines. Lancet Oncol 2020;21(8):e386-e397（国际胃癌联合会；PubMed 32758476） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

37. 学术研究 Roberts ME, et al. Comparison of CDH1 Penetrance Estimates in Clinically Ascertained Families vs Families Ascertained for Multiple Gastric Cancers. JAMA Oncol 2019;5(9):1325-1331（PubMed 31246251） doi.org ↗ ↑

38. 学术研究 Jun JK, et al. Effectiveness of the Korean National Cancer Screening Program in Reducing Gastric Cancer Mortality. Gastroenterology 2017;152(6):1319-1328（巢式病例对照；PubMed 28147224） doi.org ↗ ↑

39. 学术研究 Katai H, et al. Five-year survival analysis of surgically resected gastric cancer cases in Japan: a retrospective analysis of more than 100,000 patients from the nationwide registry of the Japanese Gastric Cancer Association (2001-2007). Gastric Cancer 2018;21(1):144-154（PubMed 28417260） doi.org ↗ ↑ ↑

40. 学术研究 Ford AC, et al. Efficacy of Helicobacter pylori eradication therapy for functional dyspepsia: updated systematic review and meta-analysis. Gut 2022（29 项随机试验 6,781 人；PubMed 35022266） doi.org ↗ ↑

41. 学术研究 Global BMI Mortality Collaboration. Body-mass index and all-cause mortality: individual-participant-data meta-analysis of 239 prospective studies in four continents. Lancet 2016;388(10046):776-786（PubMed 27423262） doi.org ↗ ↑

42. 学术研究 Chen Z, et al. Body mass index and mortality in China: a 15-year prospective study of 220 000 men. Int J Epidemiol 2012;41(2):472-481（PubMed 22296991） doi.org ↗ ↑

43. 学术研究 De Laet C, et al. Body mass index as a predictor of fracture risk: a meta-analysis. Osteoporos Int 2005;16(11):1330-1338（PubMed 15928804） doi.org ↗ ↑ ↑

44. 学术研究 Estour B, Galusca B, Germain N. Constitutional thinness and anorexia nervosa: a possible misdiagnosis? Front Endocrinol (Lausanne) 2014;5:175（PubMed 25368605） doi.org ↗ ↑

45. 学术研究 Bailly M, et al. Definition and diagnosis of constitutional thinness: a systematic review. Br J Nutr 2020;124(6):531-547（PubMed 32321597） doi.org ↗ ↑ ↑

46. 学术研究 Germain N, et al. Specific appetite, energetic and metabolomics responses to fat overfeeding in resistant-to-bodyweight-gain constitutional thinness. Nutr Diabetes 2014;4:e126（PubMed 25027794） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

47. 学术研究 Bouchard C, et al. The response to long-term overfeeding in identical twins. N Engl J Med 1990;322(21):1477-1482（PubMed 2336074） doi.org ↗ ↑ ↑

48. 学术研究 Levine JA, Eberhardt NL, Jensen MD. Role of nonexercise activity thermogenesis in resistance to fat gain in humans. Science 1999;283(5399):212-214（PubMed 9880251） doi.org ↗ ↑ ↑

49. 学术研究 Riveros-McKay F, et al. Genetic architecture of human thinness compared to severe obesity. PLoS Genet 2019;15(1):e1007603（PubMed 30677029） doi.org ↗ ↑

50. 官方网站 Gaddey HL, Holder KK. Unintentional Weight Loss in Older Adults. Am Fam Physician 2021;104(1):34-40（PubMed 34264616） pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

51. 学术研究 Lane JA, et al. Randomised clinical trial: Helicobacter pylori eradication is associated with a significantly increased body mass index in a placebo-controlled study. Aliment Pharmacol Ther 2011;33(8):922-929（PubMed 21366634） doi.org ↗ ↑ ↑

52. 学术研究 Slater GJ, et al. Is an Energy Surplus Required to Maximize Skeletal Muscle Hypertrophy Associated With Resistance Training. Front Nutr 2019;6:131（综述；PubMed 31482093） doi.org ↗ ↑

53. 学术研究 DiMeglio DP, Mattes RD. Liquid versus solid carbohydrate: effects on food intake and body weight. Int J Obes Relat Metab Disord 2000;24(6):794-800（PubMed 10878689） doi.org ↗ ↑

54. 学术研究 Storhaug CL, Fosse SK, Fadnes LT. Country, regional, and global estimates for lactose malabsorption in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol 2017;2(10):738-746（PubMed 28690131） doi.org ↗ ↑

55. 学术研究 Morton RW, et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. Br J Sports Med 2018;52(6):376-384（PubMed 28698222） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

56. 学术研究 Benito PJ, et al. A Systematic Review with Meta-Analysis of the Effect of Resistance Training on Whole-Body Muscle Growth in Healthy Adult Males. Int J Environ Res Public Health 2020;17(4):1285（PubMed 32079265） doi.org ↗ ↑

整理制作 · Ethan（HangZhou_XG） · 健康栏目 · 健康科普，不能代替医生的诊断和处方

← 回到健康 学课目录